ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

Elevance Health, Inc.

ELV · NYSE · ISIN US0367521038 · Health Care

Fecha de corte de los datos: **14 oct 2026** · Divisa: **USD** · Cifras en **millones**

Recomendación **Mantener**	Precio **425,27 USD**	Objetivo 12 m **446,86 USD**	Rentabilidad 12 m **+6,7 % (base +12,1 %)**
Valor intrínseco **444,43 USD · mercado 498,84**	Convicción **Baja**	Capitalización **94.623 M**	EV/EBITDA próx. 12 m **n.d.**
Deuda neta aj. / EBITDA **3,0x**			

Nombre	**Elevance Health, Inc.**	Ticker / ISIN	**ELV / US0367521038**
Mercado	**NYSE**	Índice de referencia	**S&P 500**
Sector / industria	**Health Care / Managed Health Care**	Sede · fundación	**Indianápolis (Indiana) · 2004**
		Web	**elevancehealth.com**
Precio (fecha)	**425,27 (13 oct 2026)**	Rango 52 semanas	**274,84 – 436,24**
Acciones diluidas (M)	**222,5**		
Capitalización	**94.623 M USD**	Valor empresa	**123.598 M USD**
		Próximos resultados	**21 oct 2026**

Contenido

- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».

No constituye recomendación de inversión.

Síntesis y recomendación

Mantener · Convicción Baja · Objetivo a 12 meses **446,86 USD** frente a 425,27 · Rentabilidad a 12 meses **+6,7 % (base +12,1 %)** · Valor intrínseco 444,43 USD · con la prima implícita del mercado: 498,84 (+17,3 %) · Alcista / bajista +28,3 % / -30,1 %

La recomendación y por qué. Mantener, con convicción baja. A 425,27 USD (cierre del 13-oct-2026) [43], nuestro objetivo a 12 meses es de 446,86 USD (PER × BPA ajustado de 2028e, ponderado 25/50/25): una rentabilidad del 6,7 % con el dividendo, y del 12,1 % en el caso base (469,70). El valor intrínseco, 444,43 USD, coincide casi con el objetivo, y el objetivo medio de los analistas (451,38, 22 analistas) [44] queda dentro de nuestro rango (296,13-551,89). La razón principal: la subida desde ≈ 373 USD en julio ya paga la recuperación del margen que promete la dirección, y la asimetría a 12 meses es de 0,98 veces. La convicción es baja porque las reglas discrepan: con nuestro WACC sale Mantener; con la prima implícita del mercado, el valor sube a 498,84 USD (Comprar). La subiría un 3T26 (21-oct) con el ratio de prestaciones por debajo del 89 % y una base de 2027 confirmada, o un precio por debajo de 394,53 USD.

El negocio. Franquicia Blue Cross Blue Shield en 14 estados, 2.º en seguro comercial (12 %) con 45,2 M de afiliados [1, 35], pero con el margen hundido: el ratio de prestaciones subió del 87,0 % (2023) al 90,0 % (2025) por Medicaid, Medicare Advantage y el ACA [1]. El ROIC (10,5 %) supera al WACC (8,40 %) por solo 2,1 puntos. La calidad sostiene el crecimiento proyectado solo en parte: tiene poder de precios con un año de retraso y no necesita capital, pero no gana cuota y el margen depende de tarifas públicas.

Finanzas. El FCF cayó de 7.277 M (2021) a 3.174 M (2025) y la matriz solo tiene ≈ 2.100 M de caja libre [3]: siguiendo la lección de UnitedHealth, el puente no cuenta los 9.491 M de caja consolidada, que respaldan las reservas, y el capital estatutario se descuenta como inversión.

Equipo y gobierno. Resta algo: dos guías incumplidas (2024 y 2025) [14, 42], aunque la de 2026 se ha subido dos veces y la consejera delegada compró ≈ 1 M USD en acciones [40].

Valoración. El DCF da 465,14 USD (WACC 8,40 %, valor terminal del 71 %), los escenarios ponderados 444,43 de síntesis y el PER de los comparables 405,40. El DCF inverso dice que el precio descuenta un crecimiento del 2,8 % anual (frente a nuestro 4,2 %) o un margen EBITDA final del 5,7 % (frente a nuestro 6,0 %): casi toda la normalización. A 14,0 veces nuestro BPA ajustado de 2027e, el PER ya está en su mediana de cinco años (14,2x). Nuestro BPA de 2028e (33,55) supera en un 3,3 % al consenso.

Riesgos y catalizadores. El coste médico de los negocios públicos es el riesgo dominante: el bajista (margen de 2025 prolongado) lleva a 296,13 USD a 12 meses, y cada punto de margen EBITDA vale ≈ 118 USD por acción. Catalizadores: 3T26 el 21-oct, inscripción de Medicare y del ACA hasta el 7-dic y guía de 2027 a finales de enero [49]. Los foros están divididos: los particulares de Reddit siguen bajistas mientras los analistas compran [45, 79].

Qué cambiaría la decisión. Compraríamos por debajo de 394,53 USD y venderíamos por encima de 504,13. Pasaríamos a Comprar si la guía de 2027 confirma un BPA ajustado de al menos 30 USD con el margen de Medicaid en positivo, y a Vender si el ratio de prestaciones vuelve por encima del 90 % fuera del cuarto trimestre.

Resumen ejecutivo

Confianza: Media

Recomendación: Mantener · Convicción: Baja · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **446,86 USD** (rentabilidad +6,7 % (base +12,1 %)) · Valor intrínseco: 444,43 USD (+4,5 % sobre 425,27) · con la prima implícita del mercado: 498,84 (+17,3 %)

Elevance es la mayor licenciataria de Blue Cross Blue Shield: 197.600 M USD de ingresos en 2025, 45,2 M de afiliados médicos y el 12 % del seguro comercial de EE. UU. [1, 35]. Su valor está en la marca y la red de proveedores en 14 estados, en el ratio de gastos más bajo del sector (10,6 %) y en una caja que crece con las primas. En 2024-2025 perdió margen: el ratio de prestaciones llegó al 90,0 % y el BPA ajustado bajó de 33,14 a 30,29 USD [1, 14].

A 425,27 USD el precio descuenta un margen EBITDA final del 5,7 %, casi el 6,0 % de 2023-2024, o un crecimiento del 2,8 % anual. Cotiza a 14,0 veces nuestro BPA ajustado de 2027e, en la mediana de su historia y de sus comparables (14,2x).

El mercado acierta en lo esencial. Coincidimos con el consenso en la recuperación (nuestro BPA de 2028e, 33,55 USD, está un 3,3 % por encima) y por eso el valor (444,43 USD) apenas supera el precio. Para invertir hay que creer que Medicaid vuelve a margen positivo, que las tarifas de Medicare Advantage de 2028 acompañan y que la promesa de +12 % en 2027 no se apoya en partidas no recurrentes. Es posible, pero ya está pagado.

La decisión

Elemento de la decisión	Valor
Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA 2028e, ponderado 25/50/25)	446,86 USD
Bajista / base / alcista a 12 meses	11,2x × 26,44 = 296,13 · 14,0x × 33,55 = 469,70 · 14,8x × 37,29 = 551,89
Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)	6,7 % / 12,1 %
Objetivo medio de los analistas (solo contraste)	451,38 (nuestro base +4,1 %)
Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)	444,43 USD
Potencial sobre el precio actual	4,5 %
Rentabilidad por dividendo ordinario	1,6 %
Rentabilidad total esperada a 12 meses	6,1 %
Escenario alcista / bajista	28,3 % / -30,1 %
Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)	0,94x
Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado	9,0 % frente a 8,4 % y 7,6 %
Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 7,6 %)	498,84 USD
Rentabilidad total esperada con la prima del mercado	18,9 %
Asimetría con la prima del mercado	2,39x
Regla absoluta (frente a su coste de capital)	Mantener
Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)	Comprar
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2032e) frente al previsto para su mercado	2,8 % frente a 5,7 %
¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?	En parte (3,6 % anual proyectado; sin inversión neta)
Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)	Comprar
Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)	Mantener
Convicción según los criterios (las reglas discrepan (absoluta Mantener, relativa Comprar))	Baja

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

Acción	A qué precio
Comprar	Por debajo de 394,53 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco)
Mantener	Entre 394,53 y 504,13
Vender o reducir	Por encima de 504,13 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %)

Qué cambiaría la recomendación

- Si el precio cae por debajo de 394,53 USD sin cambio en las cifras, pasaríamos a Comprar.
- Si la guía de 2027 (enero) da un BPA ajustado de al menos 30 USD con Medicaid en margen positivo, revisaríamos al alza el caso base.
- Si el ratio de prestaciones del 3T26 supera el 91 % o hay desarrollo desfavorable de reservas, pasaríamos a Vender.
- Si el precio supera 504,13 USD, venderíamos.

Dónde discrepamos del mercado

Lo que descuenta el precio.

Un margen EBITDA final del 5,7 % y un crecimiento del 2,8 % anual en 2027-2032: casi toda la vuelta a los márgenes de 2023-2024. Los analistas van más allá: 15 de 23 recomiendan comprar y el objetivo medio es de 451,38 USD [44, 45].

Lo que creemos nosotros.

Coincidimos en la recuperación y no vemos una cifra que el mercado no tenga: con nuestro coste de capital (8,40 %) el valor está un 4,5 % por encima del precio. No tenemos una visión distinta de la del mercado.

Por qué podemos tener razón.

La diferencia entre nuestro valor y el de los analistas sale de la tasa de descuento (con la prima implícita del mercado obtenemos 498,84 USD) y del riesgo de los negocios públicos, que pesamos con un bajista del 25 % al PER mínimo de cinco años.

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	465,14	+9,4 %	40 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	405,40	-4,7 %	20 %
Transacciones precedentes (no se usa)	646,76	+52,1 %	0 %
Escenarios ponderados	443,24	+4,2 %	40 %

A favor

- **Guía al alza**: BPA ajustado de 2026 subido dos veces, de ≥ 25,50 a ≥ 27,00 USD [3].
- **Franquicia Blue**: 12 % del seguro comercial y el ratio de gastos más bajo del sector (10,6 %) [1, 35].

- **Disciplina de precios**: sale de mercados de Medicaid con pérdidas (margen −1,75 % en 2026e) [17].
- **Con la prima del mercado** el valor sube a 498,84 USD (+17,3 %).
- **Compra de la consejera delegada**: ≈ 1 M USD tras la guía de 2026 [40].

En contra

- **El precio ya paga la recuperación**: rentabilidad a 12 meses ponderada del 6,7 %.
- **Poca creación de valor**: ROIC del 10,5 % frente a un WACC del 8,40 %, y ROIC incremental del 0,7 %.
- **Caja libre escasa**: ≈ 2.100 M en la matriz y FCF de 3.174 M en 2025 [3].
- **Guías incumplidas** en 2024 y 2025 [14, 42].
- **Bajista profundo**: 296,13 USD a 12 meses (−28,8 %) si el margen se queda en el de 2025.

Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

La tesis depende de que el ratio de prestaciones baje del 90 % de 2025 al ≈ 88 % con las subidas de primas y la salida de Medicaid, no con reservas favorables. La señal de que no se cumple: un ratio trimestral por encima del 90 % fuera del cuarto trimestre o una guía de 2027 por debajo de +12 % de BPA ajustado. La segunda condición es la caja: que las filiales vuelvan a pagar dividendos a la matriz y las recompras superen los 500 M al trimestre.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Nivel actual	Umbral de alerta	Por qué importa
Ratio de prestaciones	89,7 % (2T26); 90,0 % en 2025	> 90 % fuera del 4T	Cada punto de margen EBITDA vale ≈ 118 USD por acción.
Días de siniestros pendientes	45,4 (30-jun-26)	< 43	Separa la mejora real de la contable.
Caja de la matriz	≈ 2.100 M (30-jun-26)	< 1.500 M	Limita recompras y dividendos [3].
Guía de BPA ajustado de 2027	+12 % sobre 2026 (≈ 30,2 USD)	< 29 USD	Base de nuestro BPA de 2028e.
Margen de Medicaid	−1,75 % (2026e)	Sin mejora en 2027	Mayor palanca del margen [17].

Datos clave

EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m	**12,8x / n.d.**	PER últimos 12 m / próx. 12 m	**18,0x / 14,8x**
EV/EBIT últimos 12 m	**15,2x**		
EV/Ventas últimos 12 m	**0,62x**	Rentabilidad por FCF	**3,4 %**
Rentabilidad por dividendo	**1,6 %**	Crecimiento anual de ingresos (2021-2025)	**9,6 %**
Margen EBITDA últimos 12 m	**4,8 %**	ROIC último ejercicio	**10,5 %**
WACC	**8,4 %**	Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada)	**3,0x · 3,0x**
Gobierno (criterios cumplidos)	**7 de 13 (5 sin dato)**		

Parte I — Negocio y sector

1. Historia e hitos

Confianza: Media

Elevance Health nace en 2004 de la fusión de Anthem (Indiana) y WellPoint (California), las dos mayores licenciatarias de Blue Cross Blue Shield. Como WellPoint compró Amerigroup en 2012 (Medicaid) y volvió a llamarse Anthem en 2014; su intento de comprar Cigna (2015) lo bloquearon los tribunales en 2017. Desde 2017, con Gail Boudreaux de consejera delegada, ha añadido servicios: gestor de farmacia propio (IngenioRx, hoy CarelonRx, desde 2020), Beacon Health Options (salud conductual, 2020), MMM de Puerto Rico (2021), BioPlus (2023), Paragon y CareBridge (2024-2025). En 2022 cambió el nombre a Elevance Health y agrupó los servicios en Carelon [1].

Año	Hito
2004	Fusión de Anthem y WellPoint.
2012	Compra de Amerigroup: entrada en Medicaid gestionado.
2017	Los tribunales bloquean la compra de Cigna; Gail Boudreaux, consejera delegada.
2020	Lanza su propio gestor de farmacia (IngenioRx, hoy CarelonRx) y compra Beacon Health Options.
2022	Cambia el nombre a Elevance Health; los servicios pasan a Carelon.
2024	Retira la compra de Blue Cross Blue Shield de Luisiana; compra CareBridge y Paragon.
2025	Ratio de prestaciones del 90,0 % y recorte de la guía; BPA ajustado de 30,29 USD frente a 33,14 en 2023.
2026	Pago de 342 M a CMS por el caso de Medicare Advantage; salida de mercados de Medicaid y guía subida a ≥ 27 USD .

2. Modelo de negocio

Confianza: Media

Elevance Health es la segunda aseguradora de salud de EE. UU. por afiliados en seguro comercial y la mayor licenciataria de Blue Cross Blue Shield: 45,2 M de afiliados médicos a cierre de 2025 en planes de empresa (asegurados y de autoservicio, ASO), individuales del ACA, Medicare Advantage y Medicaid gestionado [1]. Opera en cuatro negocios: Health Benefits (las primas, ≈ 83 % de los ingresos: 164.639 M de primas sobre 197.600 M de ingresos operativos en 2025) [1], CarelonRx (gestor de farmacia propio desde 2020 y farmacia especializada), y Carelon Services (salud conductual, atención domiciliaria y pacientes complejos tras comprar CareBridge y Paragon) [1]. Sus clientes son empresas, particulares y, sobre todo, el Estado: Medicaid y Medicare pagan la parte pública de las primas.

Cómo gana dinero

Cobra primas por adelantado y paga la atención médica después: el margen es la diferencia entre la prima y el coste médico (ratio de prestaciones: 90,0 % de las primas en 2025, 88,5 % en 2024 y 87,0 % en 2023) menos los gastos operativos (10,6 % de los ingresos en 2025) [1]. Un punto de ratio de prestaciones sobre ≈ 165.000 M de primas son ≈ 1.650 M de resultado antes de impuestos, unos 5,7 USD por acción (estimación propia). La prima se fija con un año de antelación (comercial) o la fija el Estado (Medicare Advantage, Medicaid), así que un salto del coste médico se come el margen un año y se recupera con retraso. Gana además el rendimiento de la cartera de las filiales reguladas y los márgenes de CarelonRx y Carelon Services sobre los propios afiliados. Estacionalidad: el primer trimestre es el mejor (BPA ajustado de 12,58 USD en el 1T26) y el cuarto el peor (3,33 USD en el 4T25) por los deducibles y Part D [2, 4].

Clientes, recurrencia y poder de precios

No hay concentración en un cliente privado, pero sí en el pagador público: Medicaid (contratos estatales que se licitan cada 3-5 años) y Medicare Advantage (tarifas fijadas por CMS cada año) pesan mucho en el riesgo. El poder de precios se ve en 2026: la empresa ha subido las primas («premium yields») y ha salido de mercados de Medicaid y de condados del ACA y de Medicare Advantage con pérdidas, aceptando perder afiliados: los ingresos crecen un 1,5 % y

un 0,8 % en el 1T y el 2T26 con menos afiliados de riesgo [3, 4, 17]. En Medicaid los estados no han subido las tarifas al ritmo del coste: la dirección prevé un margen operativo de −1,75 % en 2026 [17].

Indicadores operativos

Indicador	Anterior	Actual	Variación	Lectura
Ratio de prestaciones (benefit expense ratio, año)	88,5 % (2024)	90,0 % (2025)	+150 pb	Coste médico por encima de lo previsto en ACA, Medicaid y Medicare [1].
Ratio de prestaciones (trimestre)	86,8 % (1T26)	89,7 % (2T26)	+80 pb interanual en el 2T	Coste médico elevado en los negocios públicos; el ACA compensa en parte [3, 10].
Ratio de gastos operativos ajustado	10,6 % (2025)	11,0 % (2T26)	+100 pb interanual	Inversiones aceleradas en capacidades [3].
Días de siniestros pendientes de pago	n. d.	45,4 días (30-jun-26)	–	Indicador de la prudencia de las reservas [3].
Afiliados médicos	45,7 M (2024, aprox.)	45,2 M (2025)	≈ −1 %	Caen Medicare Advantage, Medicaid y grupo con riesgo; sube el ACA hasta junio de 2026 [4, 12].

3. Sector y mercado

Confianza: Media

El mercado relevante es el gasto sanitario de EE. UU., donde UnitedHealth cobra primas y servicios: las cuentas nacionales de salud de CMS (National Health Expenditures) lo miden en 5,28 billones de USD en 2024 [22]. Dentro de él, los subsectores de UnitedHealth son el seguro privado (1,64 billones en 2024), Medicare (1,12 billones, del que Medicare Advantage cubre al 55 % de los beneficiarios elegibles en 2026) y Medicaid (0,93 billones), además de los fármacos de receta (467.000 M) que intermedian los gestores de farmacia [22, 25]. Se usa la serie oficial de la Oficina del Actuario de CMS [24]; la segunda fuente, la propia UnitedHealth, sitúa el gasto sanitario en el 19 % del PIB en 2025 [20], frente al 18,0 % de 2024 de CMS [22].

Tamaño del mercado	**5,28 billones de USD en 2024 (18,0 % del PIB) y 5,66 billones estimados en 2025; CMS proyecta 9,0 billones en 2034 [22, 23, 24].**	Posición en el ciclo	**Recuperación**
Crecimiento histórico anual	**6,8 %**	Crecimiento previsto anual	**5,7 %**
Cuota de los 5 primeros	**57 %**	Estructura	**Concentrada**



Motores de la demanda

Motor	Efecto	Horizonte	Evidencia
Envejecimiento y paso a Medicare	+	Estructural	La población de 65 años o más crece un 2,8 % en 2025 y un 2,7 % en 2026; CMS prevé que el gasto de Medicare crezca un 7,7 % anual en 2025-34, frente al 5,0 % del seguro privado [23, 24].
Penetración de Medicare Advantage	+	Estructural	El 55 % de los beneficiarios elegibles (35,2 M) está en Medicare Advantage en 2026, frente al 19 % en 2007; la CBO prevé el 63 % en 2034, aunque el crecimiento se frena (+3 % en 2026) [25].
Utilización y coste médico	–	Cíclico	En 2025 subió el ratio de siniestralidad de todo el sector: UnitedHealth del 85,5 % al 89,1 %, Elevance del 88,5 % al 90,0 %, Centene del 88,3 % al 91,9 % y Molina del 89,1 % al 91,7 % [1, 20, 29, 30]. CMS prevé que el gasto se modere del 7,3 % en 2025 al 6,3 % en 2026 por menor utilización [23].
Tarifas de Medicare Advantage y ajuste por riesgo	+/–	Cíclico	Subida de pagos del 5,06 % en 2026 y del 2,48 % en 2027 (4,98 % con la tendencia de puntuaciones de riesgo); la revisión del modelo de riesgo resta un 1,12 % en 2027 y la exclusión de diagnósticos de revisiones de historias no vinculadas, un 1,53 % [31, 33].
Recortes de Medicaid y fin de los subsidios reforzados del ACA	–	Estructural	CMS prevé 3,7 M menos de asegurados en compra directa en 2026 por el fin de los subsidios reforzados y 2,6 M menos en Medicaid en 2027-28 por los requisitos de la ley OBBBA; el seguro de la población baja del 91,8 % en 2024 al 90,4 % en 2028 [23].
Fármacos de especialidad y GLP-1	+/–	Estructural	El gasto en fármacos de receta crece un 11,1 % en 2025 (518.700 M) por diabetes y obesidad [23]; más volumen para los gestores de farmacia y más coste para las aseguradoras. Optum Rx gestionó 87.000 M en especialidad en 2025 [20].

Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada

Poder de los proveedores

Fuerza	Intensidad (1-5)	Justificación
Rivalidad	4	Los afiliados cambian de aseguradora cada año: en Medicare Advantage Humana ganó 1,3 M de afiliados en 2026 y UnitedHealth perdió 647.000 [25]. Los márgenes operativos de 2025 fueron bajos: del −3,9 % de Centene al 4,2 % de UnitedHealth [1, 20, 26, 27, 28, 29, 30].
Poder de los clientes	4	El Estado fija el precio en Medicare y Medicaid: CMS propuso una subida de solo el 0,09 % para 2027 y es el 44 % de los ingresos de UnitedHealth [20, 32]. Las grandes empresas se autoaseguran: 21,5 M de los 29,7 M de afiliados comerciales de UnitedHealth están en contratos de solo administración [20].
Poder de los proveedores	4	El gasto hospitalario creció un 8,9 % en 2024 [22]. UnitedHealth atribuye el coste comercial elevado a precios de los proveedores, servicios agrupados por visita y al arbitraje de la ley No Surprises [21]. Los laboratorios fijan el precio de los fármacos de especialidad.
Amenaza de entrada	2	Hacen falta capital regulado, redes de proveedores y escala: los cinco mayores tienen el 57 % del seguro comercial y en el 97 % de las áreas metropolitanas el mercado está muy concentrado [35]. Hay entrantes en Medicare Advantage: Devoted Health ganó 258.000 afiliados en 2026 [25].
Amenaza de sustitutos	2	El sustituto de Medicare Advantage es Medicare tradicional (el 45 % de los elegibles sigue en él) [25]; el del seguro con riesgo, el autoaseguramiento de la empresa, que UnitedHealth también administra [20].

Ciclo

El sector viene de un ciclo de siniestralidad alta: en 2025 el ratio de siniestralidad subió entre 1,5 y 3,6 puntos en las grandes aseguradoras y Centene registró un deterioro de 6.700 M [1, 20, 29, 30]. En 2026 las primas se han subido y se han recortado prestaciones y afiliados: el MCR de UnitedHealth bajó al 86,7 % en el 2T26 con 860 M de desarrollo favorable de ejercicios anteriores [21, 37]. En 2020 la utilización se hundió (el gasto del seguro privado creció solo un 0,4 %) y repuntó en 2023 (+11,2 %) [24]. La serie de CMS no cubre 2008-09.

Regulación

Medicare Advantage: CMS subió los pagos un 5,06 % para 2026 (más de 25.000 M) y, tras proponer un 0,09 % el 26-ene-2026, fijó un 2,48 % para 2027 el 6-abr-2026 (más de 13.000 M; 4,98 % con la tendencia de riesgo); renunció al nuevo modelo de riesgo de 2027 y mantiene el de 2024 (V28), pero excluye diagnósticos de revisiones de historias no vinculadas [31, 32, 33]. Farmacia: la ley de presupuestos firmada a principios de febrero de 2026 desvincula la remuneración de los gestores de farmacia del precio de los fármacos en Part D y obliga a trasladar los descuentos [36]. ACA: expiraron los subsidios reforzados (−3,7 M asegurados en 2026) [23]. Medicaid: la ley OBBBA limita impuestos a proveedores y pagos dirigidos y exige requisitos de trabajo [23].

Tendencias y disrupción

Tres tendencias pesan en las cifras. Primera, la integración vertical: aseguradora, gestor de farmacia y médicos propios en un mismo grupo (UnitedHealth con Optum, CVS con Aetna y Caremark, Cigna con Express Scripts); es la base del modelo de UnitedHealth, pero atrae la regulación de los gestores de farmacia [36]. Segunda, el paso de pago por acto a atención basada en valor, que en 2025 dio pérdidas a Optum Health (−278 M) por la reducción de las tarifas de Medicare [20]. Tercera, la caída de la cuota de los grandes en Medicare Advantage frente a Humana, Kaiser y aseguradoras nuevas (Devoted, SCAN) [25]. La inteligencia artificial y la regulación de datos aparecen como riesgo y oportunidad en el 10-K [20].

4. Posición competitiva y foso

Confianza: Media

Cuota de mercado	**12,0 %**	Posición	**2.° en seguro médico comercial en EE. UU. (12 % de los afiliados en 2024, detrás de UnitedHealth con el 16 %) [35]; ≈ 5 % de Medicare Advantage [25]; uno de los mayores en Medicaid gestionado y en el ACA. Sus ingresos de 2025 equivalen al 3,5 % del gasto sanitario nacional estimado (estimación propia: 197.600 M sobre 5,66 billones) [1, 24].**
Foso	**Estrecho**	Tendencia del foso	**Estable**

Competidor	País	Cotiza	Ingresos (M)	Cuota	M. EBIT	Cómo compite
UnitedHealth Group	EE. UU.	UNH	447.567	16,0 %	4,2 %	1.° en seguro comercial (16 %) y en Medicare Advantage (26 %), con Optum (servicios, tecnología y farmacia). Ratio de siniestralidad del 89,1 % en 2025 [20, 25, 35].
CVS Health (Aetna, CVS Caremark)	EE. UU.	CVS	402.067	12,0 %	1,2 %	Modelo integrado como UnitedHealth: aseguradora (26,6 M de afiliados médicos, MBR del 91,2 %), Caremark (1.900,7 M de recetas) y farmacias. Beneficio operativo de 4.660 M en 2025. Cuota en Medicare Advantage [25, 27].
The Cigna Group (Express Scripts, Evernorth)	EE. UU.	CI	274.900	–	3,3 %	Líder en gestión de farmacia: Express Scripts procesó 2.220 M de recetas en 2025 (≈31 % del mercado, estimación propia) [34]. Vendió Medicare Advantage a HCSC; 18,1 M de clientes médicos y MCR del 84,4 % en Cigna Healthcare [26].
Centene	EE. UU.	CNC	194.777	–	-3,9 %	Líder en Medicaid gestionado y en el seguro individual del ACA; 27,6 M de afiliados y HBR del 91,9 %. Pérdida operativa de 7.623 M en 2025 por un deterioro de fondo de comercio de 6.700 M [29].
Humana	EE. UU.	HUM	129.664	20,0 %	2,1 %	2.° en Medicare Advantage y el que más crece (+1,3 M de afiliados en 2026) [25]. Ratio de prestaciones del 90,2 % y 15,0 M de afiliados médicos en 2025; CenterWell (atención primaria y domiciliaria) compite con Optum Health [28].
Molina Healthcare	EE. UU.	MOH	45.426	–	1,7 %	Medicaid, Medicare y ACA; 5,5 M de afiliados y MCR del 91,7 % en 2025 (89,1 % en 2024); compite con Community & State en concursos estatales [30].



Fuentes de ventaja competitiva



Fuente	Puntuación (0-5)	Evidencia
Efectos de red	2	La red de proveedores de Blue Cross Blue Shield (descuentos negociados en 14 estados) atrae a empresas, pero el afiliado no gana valor con más afiliados [7].
Costes de cambio	2	Los contratos de seguro se renuevan cada año; el grupo de empresa (ASO) es más estable que Medicare Advantage o Medicaid, que se licitan o se eligen cada año [7].
Intangibles (marca, patentes, licencias)	4	Licencia exclusiva de la marca Blue Cross Blue Shield en 14 estados: es la principal barrera y explica el 12 % de cuota en seguro comercial [7, 17].
Ventaja en costes	3	Ratio de gastos operativos del 10,6 % en 2025, el más bajo entre las grandes (UnitedHealth 13,3 %, Humana 12,0 %) [1, 7, 10].
Escala eficiente	3	45,2 M de afiliados médicos: escala local para negociar con hospitales, pero menor que UnitedHealth (49,8 M) y sin una Optum [7].

Amenazas

La regulación es la amenaza principal: Medicaid (recortes de la ley OBBBA y redeterminaciones), ajuste de riesgo de Medicare Advantage (V28 y fuentes de diagnóstico) y el fin de los subsidios reforzados del ACA reducen afiliados e ingresos por miembro justo en los negocios públicos donde Elevance perdió margen en 2025 [31, 32]. En comercial, la presión viene de los hospitales (consolidación) y de los fármacos GLP-1 y de especialidad. Es una erosión de margen, no de la franquicia Blue.

Parte II — Finanzas

5. Cuenta de resultados

Confianza: Media

Periodo	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	EBIT	M. EBIT	B. neto	BPA	DPA	Tipo imp.
2021	136.943	–	10.095	7,4 %	8.793	6,4 %	6.104	24,73	4,52	23 %
2022	155.723	+13,7 %	9.814	6,3 %	8.451	5,4 %	5.894	24,81	5,12	23 %
2023	170.209	+9,3 %	10.169	6,0 %	8.745	5,1 %	5.987	25,22	5,84	22 %
2024	175.204	+2,9 %	10.574	6,0 %	9.089	5,2 %	5.980	25,68	6,52	25 %
2025	197.600	+12,8 %	9.658	4,9 %	8.112	4,1 %	5.662	25,21	6,84	16 %

Crecimiento anual compuesto 2021-2025: ingresos **9,6 %**, EBITDA **-1,1 %**, BPA **0,5 %**.



Los ingresos operativos crecieron de 136.943 M (2021) a 197.600 M (2025), con un salto del 12,8 % en 2025 por las subidas de primas, CarelonRx y las compras de servicios (CareBridge, Paragon) [1, 2]. El beneficio no acompañó: el EBIT (antes de intereses, con la renta de la cartera) se quedó en 8.112 M en 2025 frente a 8.793 M en 2021, y el margen EBITDA pasó del 7,4 % de 2021 al 6,0 % de 2023-2024 y al 4,9 % en 2025. La causa es el coste médico: el ratio de prestaciones subió del 87,0 % (2023) al 90,0 % (2025), con el 4T25 al 93,5 % por el ACA y Part D [1, 2]. El beneficio por acción se sostuvo (25,21 USD en 2025 frente a 24,73 en 2021) por las recompras (de 246,8 a 224,6 M de acciones) y por un tipo impositivo del 15,6 % en 2025, frente al 24,5 % de 2024 [1].

Ajustes y partidas no recurrentes

Elevance publica un BPA ajustado que excluye la amortización de intangibles comprados (≈ 628 M al año), los costes de reorganización («business optimization»), resultados de inversiones y litigios: 30,29 USD en 2025 frente a 25,21 contables, y una guía de 2026 de al menos 27,00 frente a 20,10 contables [2, 3]. La diferencia de 2026 incluye el pago de 342 M a CMS [12]. Según la dirección, 2025 llevaba ≈ 3,75 USD por acción de partidas favorables no recurrentes [2], y el 1T26 ≈ 1 USD de renta de inversiones no recurrente [4]. La cuenta del informe es la contable; el objetivo a 12 meses usa el BPA ajustado de forma coherente en historia y escenarios.

6. Resultados recientes

Confianza: Media

Periodo	Ingresos	Crec. interanual	BPA	Frente al consenso
1T25	48.800	–	11,97	–
2T25	49.400	–	8,84	Inferior
3T25	50.100	–	6,03	–
4T25	49.300	+10,0 %	3,33	En línea
1T26	49.500	+1,5 %	12,58	Superior
2T26	49.800	+0,8 %	7,45	Superior



Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

En el 2T26 (15-jul) la dirección subió por segunda vez la guía de BPA ajustado de 2026, a al menos 27,00 USD (≥ 25,50 en enero, ≥ 26,75 en abril), y el flujo operativo a al menos 6.000 M, con un BPA ajustado de 7,45 USD frente a un consenso de ≈ 6,18 [3]. El mensaje cambió entre conferencias: en abril el tono era de prudencia con un ratio de prestaciones del 86,8 % [10]; en julio, de recuperación con el ratio en el 89,7 % (+80 pb) por los negocios públicos, compensados por el ACA, y con más gasto en capacidades (gastos operativos ajustados del 11,0 %, +100 pb) [3]. Los analistas preguntaron por Medicaid, donde la empresa prevé un margen del −1,75 % y saldrá de más estados en 12-18 meses [17], y por la base de 2027: la dirección reafirmó volver a crecer al menos un 12 % el BPA ajustado sobre 2026 sin aclarar cuánto de 2026 es no recurrente (≈ 0,80 USD de partidas bajo el resultado operativo en el 2T) [3]. El margen operativo ajustado del 2T26 fue del 3,6 % frente al 5,0 % un año antes [3].

7. Balance y capital circulante

Periodo	Activo total	Fondo com. + intang.	Circulante	Caja	Deuda fin.	Arrend.	Deuda neta	Patrimonio	DN/ EBITDA
2021	97.460	34.843	0	4.880	23.330	0	18.450	36.060	1,8x
2022	102.752	34.698	0	7.387	24.350	0	16.963	36.307	1,7x
2023	108.928	35.590	0	6.526	25.270	0	18.744	39.306	1,8x
2024	116.889	40.371	0	8.288	31.490	0	23.202	41.315	2,2x
2025	121.494	39.544	0	9.491	32.046	0	22.555	43.882	2,3x

Periodo	Circulante / ventas	Liquidez corriente
2021	0,0 %	1,5x
2022	0,0 %	1,4x
2023	0,0 %	1,4x
2024	0,0 %	1,4x
2025	0,0 %	1,5x

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

La deuda financiera pasó de ≈ 23.330 M (2021, estimación) a 32.046 M (2025) por las compras de servicios y las recompras, y se mantiene en ≈ 31.075 M a 30-jun-2026 (30.700 M a largo plazo y 375 M a corto) [1, 7, 11]. La deuda neta del motor (22.555 M a cierre de 2025, 2,34 veces el EBITDA) resta la caja consolidada; con solo la caja de la matriz, la deuda neta del puente es de ≈ 28.975 M, ≈ 3,0 veces el EBITDA de 2025. La cobertura de intereses cae a 5,8 veces. El patrimonio sube a 43.882 M y el ratio deuda sobre capital ronda el 41 % (estimación propia con el patrimonio de ≈ 45.000 M de junio) [11], cerca del 40 % que suele tolerar el rating. El circulante comercial no se ha podido calcular (sin la nota de clientes y proveedores).

8. Flujos de caja

Confianza: Media

Periodo	Flujo operativo	Capex	Arrend.	FCF	B. neto	FCF / B. neto	Capex / ventas	Capex / amort.	FCF por acción
2021	8.364	1.087	0	7.277	6.104	119 %	0,8 %	0,8x	29,49
2022	8.399	1.152	0	7.247	5.894	123 %	0,7 %	0,8x	30,50
2023	8.061	1.296	0	6.765	5.987	113 %	0,8 %	0,9x	28,50
2024	5.808	1.256	0	4.552	5.980	76 %	0,7 %	0,8x	19,54
2025	4.290	1.116	0	3.174	5.662	56 %	0,6 %	0,7x	14,13



Acumulado 2021-2025: FCF **29.015**, conversión **98 %** del beneficio neto; adquisiciones 0, dividendos 6.756, recompras 12.401.

La conversión del beneficio en caja se ha deteriorado: el flujo operativo bajó de 8.364 M (2021) a 5.808 M (2024) y 4.290 M (2025), frente a un beneficio de 5.662 M; el FCF de 2025 (3.174 M) es la mitad del de 2021 (7.277 M) [2, 6]. La causa no es el capex (0,6-0,8 % de las ventas, 1.116 M en 2025) sino el circulante de un asegurador que crece en negocios públicos con cobros de CMS y de los estados más lentos, y el pago de siniestros de años anteriores [6]. La guía de 2026 de al menos 6.000 M de flujo operativo devolvería la conversión al ≈ 130 % del beneficio contable [3]. En 2021-2025 el FCF acumulado (29.015 M) cubrió dividendos (6.756 M) y recompras (12.401 M); el resto, con deuda, fue a compras de servicios (sin la línea anual de adquisiciones en las fuentes). Casi todo el capex es de mantenimiento y tecnología (estimación propia).

9. Calidad contable

Confianza: Media

Auditor	**Ernst & Young LLP**		
Opinión del último informe	**Favorable**	Ejercicio analizado	**2025**

Indicador	Valor	Lectura
Altman Z	2,80	Zona gris (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo.
Piotroski F	6 / 8	Intermedio (4-6).
Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)	1,18x	El beneficio se cobra.

Criterio Piotroski	Cumple
Beneficio neto positivo	Sí
Flujo operativo positivo	Sí
ROA mejora	No
Flujo operativo > beneficio neto	No
Baja el endeudamiento (deuda / activo)	Sí
Mejora la liquidez corriente	Sí
No emite acciones	Sí
Mejora el margen bruto	n.d.
Mejora la rotación del activo	Sí

Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

Las cifras son fiables en lo básico (auditor Ernst & Young, opinión favorable) [1], pero el beneficio ajustado se aleja del contable: 5,08 USD por acción en 2025 y ≈ 6,90 en la guía de 2026, por amortización de intangibles, reorganizaciones recurrentes y el pago a CMS [2, 3]. Las reorganizaciones se repiten casi todos los años, así que no las tratamos como no recurrentes en el DCF (el margen de 2026e es el contable). Las reservas médicas son la gran estimación: un desarrollo favorable de años anteriores puede maquillar un trimestre; los días de siniestros pendientes (45,4 en junio) son el indicador a vigilar [3]. El Altman Z (2,80, zona gris) no sirve para aseguradoras, cuyo pasivo son reservas; el Piotroski F de 6 señala ROA a la baja y flujo operativo por debajo del beneficio en 2025, coherente con lo anterior. El Beneish M no se calcula (sin clientes ni coste de ventas).

Señales de alerta

Señal	Nivel	Explicación
Flujo operativo por debajo del beneficio en 2025 (4.290 M frente a 5.662 M)	Media	Cobros públicos más lentos y pago de siniestros; la guía de 2026 (≥ 6.000 M) lo corregiría [2, 3].
Diferencia creciente entre BPA ajustado y contable (≈ 6,90 USD en 2026)	Media	Incluye costes de reorganización que se repiten y el pago a CMS [3, 12].
Tipo impositivo del 15,6 % en 2025 frente al 24,5 % de 2024	Baja	Partidas fiscales favorables no recurrentes; el DCF usa el 23 % [1].

10. Rentabilidad sobre el capital

Confianza: Media

Periodo	ROIC	ROE	ROA	Margen neto	Rotación del activo	Apalancamiento	Capital invertido
2021	12,4 %	16,9 %	6,3 %	4,5 %	1,41x	2,70x	54.510
2022	12,1 %	16,3 %	5,9 %	3,8 %	1,56x	2,77x	53.890
2023	12,2 %	15,8 %	5,7 %	3,5 %	1,61x	2,80x	55.660
2024	11,2 %	14,8 %	5,3 %	3,4 %	1,55x	2,80x	61.284
2025	10,5 %	13,3 %	4,8 %	2,9 %	1,66x	2,80x	65.477



ROIC incremental (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): 0,7 % · **WACC**: 8,4 %.

Elevance crea valor, pero poco: el ROIC bajó del 12,4 % (2021) y el 12,1-12,2 % (2022-2023) al 11,2 % (2024) y al 10,5 % (2025), frente a un WACC del 8,40 %: 2,1 puntos de diferencia. La causa es el margen, no la rotación: el margen neto cayó del 4,5 % al 2,9 % mientras la rotación del capital subía de 1,41 a 1,66 veces. El ROIC incremental de 2021-2025 es del 0,7 %: el capital invertido creció 11.927 M (compras de Carelon, fondo de comercio de 24.228 a 28.344 M) y el NOPAT se quedó plano (6.763 frente a 6.844 M). Dos matices: el NOPAT incluye la renta de la cartera regulada y el capital invertido resta la caja consolidada, así que el ROIC económico es algo menor (estimación propia). Frente a UnitedHealth (12,5 %) queda por debajo, y por encima de Centene, Molina y Humana, con márgenes negativos o mínimos en 2025 [28, 29, 30].

11. Deuda y solvencia

Confianza: Media

Deuda neta a 30 jun 2026	**28.975 M**	Deuda neta / EBITDA últimos 12 m	**3,0x**
Deuda neta ajustada / EBITDA	**3,0x**	Liquidez disponible	**Caja y equivalentes consolidados de 9.491 M a 31-dic-2025, pero solo ≈ 2.600 M de caja e inversiones en la matriz (no regulada); ≈ 2.100 M a 30-jun-2026 [2, 3].**
		Coste medio de la deuda	**4,9 %**



Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

El pasivo relevante que no es deuda son las reservas médicas (siniestros pendientes de pago, 45,4 días a 30-jun-2026) y los cobros anticipados de primas [3]; respaldan la caja y las inversiones de las filiales reguladas, que no son de libre uso: de los 9.491 M de caja consolidada de cierre de 2025, la matriz solo tenía ≈ 2.600 M de caja e inversiones, y ≈ 2.100 M a 30-jun-2026 [2, 3]. Las filiales deben mantener capital estatutario (capital basado en riesgo) que crece con las primas; esa caja solo sube a la matriz como dividendo autorizado por los reguladores estatales. No hay pensiones relevantes ni arrendamientos financieros significativos (US GAAP: los operativos ya están en el EBITDA). El pago de 342 M a CMS cerró sin sanciones un expediente de Medicare Advantage [12].

12. Asignación de capital

Confianza: Media

Dividendo trimestral de 1,72 USD en 2026 (6,88 USD al año, ≈ 1,6 % de rentabilidad), subido cada año desde 2011, y recompras: 2.605 M en 2025 y solo 234 M en el 2T26 (0,7 M de acciones a 344,62 USD), un ritmo menor que el de 2022-2024 (2.300-2.900 M al año) [3, 13]. La prioridad declarada es invertir en capacidades (Carelon) y mantener la deuda sobre capital en torno al 40 %; la caja de la matriz (≈ 2.100 M) limita las recompras hasta que las filiales vuelvan a pagar dividendos [3].

Periodo	FCF	Dividendos	Recompras	Ampliaciones	Retorno / B. neto	Acciones (M)
2021	7.277	1.104	1.900	0	49 %	246,8
2022	7.247	1.229	2.316	0	60 %	237,6
2023	6.765	1.386	2.680	0	68 %	237,4
2024	4.552	1.508	2.900	0	74 %	232,9
2025	3.174	1.529	2.605	0	73 %	224,6



Historial de adquisiciones

Año	Objetivo	Importe	Financiación	Resultado
2020	Beacon Health Options (salud conductual)	2.200	Caja y deuda	Integrada en Carelon Behavioral Health; sin deterioros publicados.
2021	MMM Holdings (Medicare Advantage en Puerto Rico)	–	Caja	Integrada; el negocio de Medicare Advantage es el que más margen ha perdido en 2025-2026.
2023	BioPlus (farmacia especializada)	–	Caja	Integrada en CarelonRx.
2024	Blue Cross Blue Shield de Luisiana	–	Caja	Retirada en 2024 por la oposición del regulador estatal.
2024-2025	CareBridge y Paragon Healthcare (pacientes complejos e infusiones)	–	Caja y deuda	Fondo de comercio de 25.317 M (2023) a 28.344 M (2025) [7]; resultado aún sin demostrar.

Asignación de capital correcta pero sin rendimiento visible: en 2021-2025 devolvió 19.157 M (6.756 M en dividendos y 12.401 M en recompras), el 66 % del FCF acumulado (29.015 M), y redujo las acciones un 9 % (de 246,8 a 224,6 M). Pero el ROIC bajó del 12,4 % (2021) al 10,5 % (2025) mientras el capital invertido subía de 54.510 a 66.437 M: el ROIC incremental del periodo es del 0,7 %, porque las compras de servicios y la deuda crecieron mientras el margen del seguro se hundía. Las recompras de 2022-2023 se hicieron a 470-510 USD, por encima del precio actual. Sin pruebas de que Carelon rinda lo pagado, el veredicto es neutro.

Parte III — Equipo y gobierno

13. Equipo directivo

Confianza: Baja

Nombre	Cargo	Desde	Trayectoria y resultados
Gail K. Boudreaux	Presidenta y consejera delegada	2017	Venía de dirigir UnitedHealthcare (2008-2014). Con ella el BPA ajustado pasó de 15,87 USD (2018) a 33,14 (2023) y la empresa entró en farmacia y servicios (Carelon); en 2024-2025 incumplió dos guías seguidas [14].
Mark Kaye	Vicepresidente ejecutivo y director financiero	2023	Antes director financiero de Moody's. Remuneración de ≈ 7,09 M USD en 2025 [39].

¿Cumple lo que promete?

Año	Lo que prometió	Lo que logró	Cumplió
2023	BPA ajustado > 32,60 USD	33,14 USD	Sí
2024	BPA ajustado > 37,10 USD (enero)	≈ 33,0 USD (recortada en octubre)	No
2025	BPA ajustado ≈ 34-34,50 USD (enero)	30,29 USD	No
2026	BPA ajustado ≥ 25,50 USD (enero), subida a ≥ 26,75 (abril) y ≥ 27,00 (julio)	En curso	Parcial

Equipo estable (Boudreaux desde 2017, Kaye desde 2023) pero con credibilidad dañada: la guía de 2024 (más de 37,10 USD) acabó en ≈ 33 y la de 2025 en 30,29 frente a ≈ 34, con caídas del 12 % el día de los resultados del 3T24 y fuertes bajadas en julio de 2025 [14, 41, 42]. En 2026 la dirección guió bajo (≥ 25,50) y ha subido dos veces, lo que recupera algo de confianza [3]. Boudreaux compró ≈ 1 M USD en acciones tras la guía de 2026 [40]. No hay plan de sucesión público (Boudreaux tiene 65 años; estimación propia por su trayectoria).

14. Gobierno corporativo

Confianza: Baja

Consejeros	**1**	Independientes	**0 %**
Antigüedad media en el consejo	**9,0 años**	Criterios de buen gobierno cumplidos	**7 de 13 (5 sin dato)**
Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses)	**0**		

Consejero	Cargo	Tipo	Desde
Gail K. Boudreaux	Consejera delegada	Ejecutivo	2017

Criterio	Dato	Resultado
Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)	0 %	No cumple
Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control	Sin control	Cumple
Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente	No	Sin dato
Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno	Sí	Cumple
Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años	Ninguno	Cumple
Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses	0 cambios	Cumple
Peor voto a favor sobre remuneración (3 juntas) ≥ 80 %	Sin dato	Sin dato
Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)	Sin dato	Sin dato
Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios	Sí	Cumple
Sin operaciones vinculadas relevantes	No hay	Cumple
Auditor con 10 años o menos en el cargo	Sin dato	Sin dato
Opinión de auditoría sin salvedades	Favorable	Cumple
Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)	Sin dato	Sin dato

Remuneración

Remuneración total del primer ejecutivo (2025)	**22,58 M**	Fijo	**1,60 M**
Variable anual	**3,38 M**	Variable a largo plazo	**17,60 M**

La consejera delegada cobró 22,58 M USD en 2025 (20,5 M en 2024): 1,6 M de salario, ≈ 13,4 M en acciones y ≈ 4,2 M en opciones [39]. Con ≈ 78 % en variable a largo plazo ligado a la acción, el incentivo está alineado con el accionista; no hemos podido leer las métricas del variable ni el voto de la junta de mayo de 2026 (proxy no accesible desde la nube) [38].

Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

Sin accionista de control: el capital está repartido entre fondos indexados y gestoras; una acción, un voto [38]. Las licencias de Blue Cross Blue Shield Association limitan quién puede comprar la empresa (la asociación exige que la mayoría del capital no la tenga un tercero sin su aprobación), lo que funciona como una defensa de hecho frente a una OPA (estimación propia sobre los contratos de licencia descritos en el 10-K) [1].

Señales de alerta

- Pago de 342 M a CMS en el 2T26 para cerrar un expediente de Medicare Advantage [3].
- Dos guías anuales incumplidas seguidas (2024 y 2025) [14, 41, 42].
- Compra de acciones de la consejera delegada por ≈ 1 M USD tras la guía de 2026 (señal positiva) [40].

Parte IV — Mercado y valoración

15. Previsiones de la compañía y consenso

Confianza: Media

Guía de 2026 (15-jul-2026): BPA ajustado de al menos 27,00 USD (≥ 25,50 en enero y ≥ 26,75 en abril), BPA contable de al menos 20,10 USD y flujo operativo de al menos 6.000 M; la dirección reafirma un crecimiento de al menos el 12 % del BPA ajustado en 2027 sobre la base de 2026 [2, 3, 4]. Resultados del 3T26 el 21-oct-2026 antes de la apertura, con conferencia a las 8:30 [49, 50].

Periodo	BPA	DPA	Fuente
2026e	26,92	6,88	Barchart (consenso tras el 2T26) [47]
2027e	29,12	–	Barchart [47]; Zacks 28,83 [46]
2028e	32,49	–	Zacks Research [46]

Nuestra proyección frente al consenso

Periodo	Ingresos propios	EBITDA propio
2026e	198.588	9.135
2027e	204.546	11.250
2028e	214.773	12.242

Analistas	**22**	Comprar / mantener / vender	**15 / 8 / 0**
Precio objetivo medio	**451,38**	Rango de precios objetivo	**360,00 – 498,00**

Revisiones de estimaciones

Las revisiones han ido al alza desde abril: la guía subió dos veces (de ≥ 25,50 a ≥ 27,00 USD) y el BPA de consenso de 2026 pasó de 25,93 a 26,92 USD [47]. En octubre BofA subió su objetivo a 480 USD, Barclays a 469 y Guggenheim a 460; Leerink, a 395 con «Market Perform» [44, 45]. El objetivo medio pasó de ≈ 381 USD (TIKR, primavera) a 441 (MarketBeat) y 451 (S&P Global, 22 analistas) [44, 45, 52]. Solo hay estimaciones de BPA (ajustado), no de ingresos ni de EBITDA, desde la nube.

17. Múltiplos frente a su historia

Confianza: Media

Múltiplo	Actual	Mediana	Mínimo	Máximo	Percentil	Prima / descuento
EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)	12,8x	12,9x	10,3x	14,1x	40 %	-1 %
PER últimos 12 meses (cierre de cada año)	18,0x	18,7x	13,9x	20,7x	40 %	-4 %



Sobre el BPA contable de los últimos doce meses, Elevance cotiza a 18,0 veces, en línea con su media de cinco años (18,7x), y a 12,8 veces el EBITDA, también en la media (12,9x). Sobre el BPA ajustado, la lectura es la misma: 15,7

veces el de 2026e (27,00) y 14,0 veces nuestro 2027e (30,46), frente a una mediana de 14,2x en 2021-2025 y unos mínimos de 11,2-11,6x en 2024-2025, cuando el mercado dudaba de los márgenes. La subida de los últimos tres meses (de ≈ 373 a 425 USD) ha devuelto el múltiplo a su mediana: ya no hay descuento frente a la historia, y la historia de 2021-2022 (17-18x) correspondía a un margen EBITDA del 6,3-7,4 % que hoy no tiene [48, 51].

18. Comparables cotizados

Confianza: Media

Las grandes aseguradoras de salud cotizadas de EE. UU. (UnitedHealth, CVS-Aetna, Cigna, Humana, Centene, Molina) y dos especialistas en crecimiento (Oscar en el ACA, Alignment en Medicare Advantage). Cifras de Stock Analysis del 9-12 oct-2026, tomadas para el informe de UnitedHealth; UnitedHealth entra con las de su propio informe. Su valor empresa resta la caja regulada: solo se usa el PER.

Empresa	País	Capitaliz.	EV/Vtas	EV/ EBITDA LTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC	DN/ EBITDA	FCF yield
Elevance	US	94.623	0,6x	12,8x	14,8x	–	4,8 %	10,5 %	3,0x	3,4 %
UnitedHealth Group	US	342.000	0,9x	14,7x	18,4x	+1,6 %	6,4 %	12,5 %	2,5x	–
The Cigna Group	US	74.629	0,3x	7,8x	8,6x	+5,0 %	4,5 %	13,4 %	1,9x	12,2 %
CVS Health	US	110.285	0,4x	10,3x	10,2x	+3,6 %	4,0 %	7,2 %	3,7x	10,7 %
Humana	US	51.859	0,4x	16,6x	28,0x	+14,8 %	2,5 %	8,1 %	2,2x	3,8 %
Centene	US	32.288	0,1x	5,3x	12,5x	+7,3 %	2,6 %	8,8 %	-2,4x	27,7 %
Molina Healthcare	US	10.258	0,2x	23,6x	22,5x	+11,2 %	0,9 %	3,7 %	-2,6x	2,6 %
Oscar Health	US	10.289	0,4x	10,2x	15,8x	+32,7 %	4,3 %	25,1 %	-5,5x	42,6 %
Alignment Healthcare	US	1.566	0,3x	13,8x	11,1x	+35,8 %	1,9 %	9,9 %	-4,2x	11,3 %

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

Estadístico	EV/Vtas	EV/EBITDA LTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC
Mediana	0,4x	12,1x	14,2x	+9,3 %	3,3 %	9,4 %
Media	0,4x	12,8x	15,9x	+14,0 %	3,4 %	11,1 %
Percentil 25	0,3x	9,6x	10,9x	+4,7 %	2,4 %	7,9 %
Percentil 75	0,4x	15,2x	19,4x	+19,3 %	4,4 %	12,7 %

Valor implícito por acción

Múltiplo aplicado	Métrica de la empresa	Múltiplo p25 / mediana / p75	Valor p25	Valor mediana	Valor p75	Potencial
EV/EBITDA últimos 12 meses	9.658	9,6x / 12,1x / 15,2x	286,48	392,83	528,47	-7,6 %
PER próximos 12 meses	28,6	10,9x / 14,2x / 19,4x	311,57	405,40	556,53	-4,7 %
EV/Ventas últimos 12 meses	200.420	0,3x / 0,4x / 0,4x	94,97	212,07	252,60	-50,1 %

Elevance cotiza a 14,8 veces el beneficio contable de los próximos doce meses según el motor, en la mediana de sus comparables (14,2x): más cara que Cigna (8,6x) y CVS (10,2x), que tienen el beneficio sostenido por sus gestores de farmacia, y más barata que UnitedHealth (18,4x) y que Humana y Molina, cuyo beneficio de 2026 está hundido [55,

56, 57, 58, 60]. Aplicado a su BPA, el PER mediano da 405,40 USD. El descuento frente a UnitedHealth es razonable (sin Optum, ROIC del 10,5 % frente al 12,5 %); la prima frente a Cigna y CVS no lo es tanto. El EV/EBITDA de los comparables no se usa: Stock Analysis resta su caja regulada y Centene, Molina, Oscar y Alignment salen con deuda neta negativa [59, 61, 62].

19. Transacciones precedentes

Confianza: Media

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2018-03	Express Scripts	Cigna	67.000	0,67x	9,2x	31 %	48,75 USD en efectivo + 0,2434 acciones por acción (54.000 M en total) y 15.000 M de deuda asumida; prima del 31 % sobre el cierre de 73,42 USD del 7-mar-2018 [66]. Múltiplos sobre 2017: ingresos 100.065 M y EBITDA 7.296 M (resultado operativo 5.494 + amortizaciones 1.802) [71] (cálculo propio).
2017-12	Aetna	CVS Health	77.000	1,27x	–	–	145 USD en efectivo + 0,8378 acciones de CVS por acción, ≈ 207 USD por acción y 69.000 M de capital; 77.000 M con la deuda asumida [67]. EV/ventas sobre los ingresos de 2017 de Aetna, 60.535 M [72] (cálculo propio).
2021-01	Change Healthcare	UnitedHealth Group (Optum)	12.521	4,05x	18,1x	–	25,75 USD por acción en efectivo [68]. Estimación propia del valor empresa: 304,45 M de acciones (27-oct-2020) × 25,75 = 7.840 M + deuda 4.818 M − caja 137 M (31-dic-2020) [73]. Múltiplos sobre el ejercicio cerrado en marzo de 2021: ingresos 3.090 M y EBITDA 691 M (resultado operativo 100 + amortizaciones 591) [73].
2023-06	Amedisys	UnitedHealth Group (Optum)	3.694	1,66x	17,9x	–	101 USD por acción en efectivo [69]. Estimación propia del valor empresa: 32,56 M de acciones × 101 = 3.289 M + deuda 400 M − caja 49 M + minoritarios 54 M (31-mar-2023) [74]. Múltiplos sobre 2022: ingresos 2.223 M y EBITDA 206 M (resultado operativo 181 + amortizaciones 25) [74].

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2022-09	Signify Health	CVS Health	8.000	12,30x	67,8x	–	30,50 USD por acción en efectivo; valor total de la operación ≈ 8.000 M [70]. Sobre 2021: ingresos 653 M y EBITDA 118 M [75] (cálculo propio). Plataforma de evaluaciones domiciliarias en crecimiento: múltiplo no comparable con un asegurador.
2023-02	Oak Street Health	CVS Health	10.600	–	–	–	39 USD por acción en efectivo, valor empresa ≈ 10.600 M; red de atención primaria con EBITDA ajustado aún negativo, que CVS espera que aporte más de 2.000 M de EBITDA ajustado «embebido» en madurez [76].
2021-04	Kindred at Home (60 % restante)	Humana	8.100	–	–	–	Valor empresa de 8.100 M para el 100 %, incluidos 2.400 M del 40 % que Humana ya tenía; 43.000 cuidadores y más de 550.000 pacientes al año [77]. La nota no publica ingresos ni EBITDA.

EV/EBITDA mediano (p25 – p75)	**17,9x (13,6x – 18,0x)**	Prima de control mediana	**31 %**
Valor por acción implícito (mediana de EV/EBITDA)	**646,76**	Rango p25 – p75	**457,94 – 651,10**



Las transacciones del sector (9-18 veces el EBITDA en piezas de servicios y farmacia: Express Scripts, Change Healthcare, Amedisys) llevan prima de control y no son de aseguradoras enteras [66, 68, 69]. Elevance no es un objetivo plausible: su tamaño (94.623 M de capitalización), la regulación antimonopolio (el bloqueo de Anthem-Cigna en 2017) y las licencias Blue lo impiden. No ponderamos las transacciones.

20. Descuento de flujos de caja (DCF)

Confianza: Media

Supuestos y su justificación

Crecimiento de ingresos.

2026e se fija en el 0,5 %: los ingresos del 1S26 crecieron un 1,1 % (49.500 y 49.800 M) con menos afiliados de riesgo y el consenso del 3T26 es de 49.290 M [3, 4, 49]. En 2027e, un 3,0 %: salida de mercados de Medicaid y del ACA (fin de los subsidios reforzados) contra subidas de primas del 5 % [17, 31]. De 2028e a 2030e, un 5,0-4,5 %, por debajo del 5,7

% anual de crecimiento del gasto sanitario de EE. UU. que proyecta CMS [24] y muy por debajo del 9,6 % anual de 2021-2025, que incluía compras. 2031e-2032e convergen al 3,5 %.

Márgenes.

El margen EBITDA de 2026e (4,6 %) sale de la guía contable (BPA ≥ 20,10 USD con ≈ 222,5 M de acciones, tipo del 23 %, intereses de ≈ 1.450 M y amortizaciones de ≈ 1.550 M; estimación propia) [3]. En 2027e sube al 5,5 %, el margen subyacente de 2026 (BPA ajustado ≥ 27) más el +12 % de BPA que promete la dirección [3]. Después sube al 6,0 % en 2030e, el de 2023-2024, sin volver al 7,4 % de 2021. Cada punto de ratio de prestaciones vale ≈ 0,8 puntos de margen EBITDA.

Inversión y circulante.

El capex de la empresa es pequeño (0,6-0,8 % de las ventas en 2021-2025) [6]; le sumamos el capital estatutario que las filiales tienen que retener al crecer (≈ 12 % del aumento de ventas, estimación propia), porque esa caja no llega al accionista. Resultado: 0,95-1,27 % de las ventas desde 2027e, por encima de la amortización (0,78 %) al final. El circulante comercial se deja en cero porque no se ha podido medir. Tipo impositivo normalizado del 23 % (24,5 % en 2024; 15,6 % en 2025 con partidas no recurrentes) [1].

Coste del capital.

Tasa libre: bono de EE. UU. a 10 años al 5,22 % (8-oct-2026) [63]. Beta de 0,85: la desapalancada de Damodaran para servicios sanitarios reapalancada con la deuda de Elevance, la misma que en UnitedHealth [65]; la de la acción sería menor y no recoge el riesgo regulatorio. Prima de mercado del 5,5 %; la implícita (4,20 %) se usa en la regla relativa [64]. Coste de la deuda del 5,0 % antes de impuestos (intereses de 1.402 M sobre ≈ 30.000 M de deuda media en 2025, y emisiones recientes por encima) [5]. Peso de la deuda del 24,7 % (31.075 M sobre 31.075 + 94.623 M). WACC del 8,40 %.

Valor terminal.

Media de Gordon (crecimiento del 3,0 %: ≈ 2,5 % de inflación más algo del crecimiento real del gasto sanitario, por debajo de la tasa libre menos medio punto) y un múltiplo de salida de 9 veces el EBITDA, por debajo de los 12,8x actuales y del mínimo de cinco años (10,3x), porque el EBITDA de salida es de margen recuperado. Gordon implica 11,4 veces el EBITDA de salida; la media modera ese múltiplo. El valor terminal pesa el 71 % del valor empresa.

Coste medio ponderado del capital

Componente	Valor
Tasa libre de riesgo	5,22 %
Beta	0,85
Prima de riesgo de mercado	5,50 %
Prima adicional (país, tamaño, específica)	0,00 %
Coste de los fondos propios	9,89 %
Coste de la deuda antes de impuestos	5,00 %
Tipo impositivo	23,00 %
Coste de la deuda después de impuestos	3,85 %
Peso de la deuda (D / (D + E))	24,70 %
WACC	8,40 %
Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa)	4,20 %
WACC con la prima implícita del mercado	7,57 %

Proyección

Año	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	Amort.	Impuestos	Capex	Δ Circ.	FCFF	Fracción	VA
2026e	198.588	0,5 %	9.135	4,6 %	1.549	1.745	1.192	0	6.199	0,21	1.312
2027e	204.546	3,0 %	11.250	5,5 %	1.595	2.221	1.943	0	7.086	1,00	6.685
2028e	214.773	5,0 %	12.242	5,7 %	1.675	2.430	2.577	0	7.234	1,00	6.300
2029e	225.512	5,0 %	13.305	5,9 %	1.759	2.656	2.864	0	7.786	1,00	6.250
2030e	235.660	4,5 %	14.140	6,0 %	1.838	2.829	2.993	0	8.317	1,00	6.160
2031e	245.086	4,0 %	14.705	6,0 %	1.912	2.943	3.039	0	8.724	1,00	5.960
2032e	253.664	3,5 %	15.220	6,0 %	1.979	3.045	3.069	0	9.105	1,00	5.742

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.

2026e 2027e 2028e 2029e 2030e 2031e 2032e

Valor terminal

Concepto	Valor
Método principal	Media de ambos
Crecimiento a perpetuidad	3,0 %
Múltiplo EV/EBITDA de salida	9,0x
Valor terminal (Gordon)	173.609
Valor terminal (múltiplo)	136.979
Múltiplo de salida implícito en Gordon	11,4x
Crecimiento implícito en el múltiplo	1,65 %
Peso del valor terminal en el valor empresa	71 %

Del valor empresa al valor por acción

Concepto	Importe
Valor actual de los flujos proyectados	38.409
Valor actual del valor terminal	94.060
Valor empresa	132.469
− Deuda financiera neta (con arrendamientos)	-28.975
− Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas	0
Valor de los fondos propios	103.494
Acciones diluidas (millones)	222,5
Valor por acción	465,14

Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

WACC	2,0 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %
7,4 %	492,72	519,34	552,01	593,06	646,17
7,9 %	457,14	478,73	504,71	536,60	576,66
8,4 %	426,29	444,07	465,14	490,51	521,64
8,9 %	399,18	414,03	431,38	451,95	476,72
9,4 %	375,09	387,62	402,11	419,06	439,14

Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

Margen \ crec.	-2 pp	-1 pp	0 pp	+1 pp	+2 pp
-2 pp	193,60	210,43	228,04	246,46	265,73
-1 pp	300,85	323,20	346,59	371,06	396,64
0 pp	408,10	435,98	465,14	495,65	527,54
+1 pp	515,35	548,75	583,69	620,24	658,45
+2 pp	622,60	661,52	702,24	744,83	789,35

¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

Veredicto: En parte.

Prueba	Valor
Crecimiento medio de ingresos proyectado	3,6 %
Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión)	1,1 % de las ventas
Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante)	5.370 M (9 % del NOPAT)

La proyección apenas necesita inversión neta de la amortización (reinversión acumulada de 5.370 M, el 9 % del NOPAT, con un capex bruto medio del 1,1 % de las ventas). En un negocio de activos ligeros, el crecimiento medio del 3,6 % tiene que salir de subir precios y de ganar volumen sin capital nuevo, y la prueba es el poder de precios y la cuota; en un comprador en serie, la amortización es de intangibles comprados y la prueba es el capex bruto (las compras) frente al crecimiento comprado.

Año	Volumen	Precio	Otros (mezcla, compras)	Crecimiento	De dónde sale
2026e	-4,0 %	+4,5 %	0,0 %	+0,5 %	Volumen −4 %: bajan los afiliados de riesgo de Medicare Advantage, Medicaid y grupo [3, 4]. Precio +4,5 %: subidas de primas («premium yields») y CarelonRx [3].
2027e	-2,0 %	+5,0 %	0,0 %	+3,0 %	Volumen −2 %: salidas de estados de Medicaid y fin de los subsidios reforzados del ACA [17]. Precio +5 %: tarifa de Medicare Advantage de 2027 (+2,48 %, ≈ 5 % con la tendencia de riesgo) y primas comerciales al ritmo del coste médico [31].
2028e	+0,5 %	+4,5 %	0,0 %	+5,0 %	Vuelve el volumen (+0,5 %) con el envejecimiento en Medicare; precio +4,5 %, en línea con el gasto sanitario por persona [24].
2029e	+0,5 %	+4,5 %	0,0 %	+5,0 %	Mismo patrón que 2028e; por debajo del 5,7 % de crecimiento del gasto nacional [24].
2030e	+0,5 %	+4,0 %	0,0 %	+4,5 %	Precio +4 % y volumen +0,5 %: Elevance ya tiene el 12 % del seguro comercial [35].

En parte. La proyección apenas pide capital (reinversión del 9 % del NOPAT, que el motor clasifica como activos ligeros), así que la prueba es el poder de precios y la cuota, hecha a mano. El precio sí lo tiene con un año de retraso: subió primas en 2026 y salió de mercados con pérdidas [3, 17]. La cuota no crece: proyectamos 3,6 % anual, menos que el gasto sanitario (5,7 %) [24]; los ingresos de 2025 son el 3,5 % del gasto nacional (5,66 billones) y los de 2028e (≈ 214.800 M) serían el 3,2 % de 6,63 billones (estimación propia) [24]. Lo exigente es el margen (del 4,6 % al 6,0 %), que la empresa ya tuvo en 2023-2024 pero que depende de que el coste médico y las tarifas públicas acompañen. El ROIC (10,5 %) apenas supera el WACC (8,40 %).

DCF inverso: qué descuenta el precio actual

Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2032e)	**2,8 % (base: 4,2 %)**
Margen EBITDA final implícito	**5,7 % (base: 6,0 %)**
Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual)	**9,0 % (WACC: 8,4 %)**

El DCF da 465,14 USD por acción, un 9,4 % por encima del precio de 425,27, con un WACC del 8,40 % y un valor terminal que pesa el 71 %. El DCF inverso dice que el precio descuenta un crecimiento anual del 2,8 % en 2027e-2032e (frente a nuestro 4,2 %) o, con nuestro crecimiento, un margen EBITDA final del 5,7 % (frente a nuestro 6,0 % y al 6,0-7,4 % de 2021-2024): el mercado ya paga casi toda la vuelta del margen a la normalidad. Dicho de otro modo, el precio rinde un 9,0 % anual, solo 0,6 puntos más que nuestro coste de capital. Nuestro BPA ajustado de 2027e (30,46 USD) y de 2028e (33,55) está un 4,6 % y un 3,3 % por encima del consenso (29,12 y 32,49) [46, 47], así que la diferencia con el precio es pequeña y sale del margen de 2029-2032. Con la prima implícita del mercado (4,20 %) el DCF sube a 535,11 USD. La variable que decide es el ratio de prestaciones: cada punto de margen EBITDA en todos los años vale ≈ 118 USD por acción (de 465,14 a 583,69 USD).

21. Escenarios

Confianza: Media

Escenario	Prob.	Crec. medio	Margen final	WACC	Valor	Potencial	Qué tiene que ocurrir
Bajista	25 %	2,2 %	5,2 %	8,9 %	297,18	-30,1 %	El coste médico de Medicaid y Medicare Advantage sigue por delante de las tarifas, los estados no suben las primas de Medicaid y el fin de los subsidios del ACA deja una cartera más enferma. El margen EBITDA se queda ≈ 0,8 puntos por debajo del base (≈ 5,2 % en 2030), los ingresos crecen 2 puntos menos al año y el mercado exige más prima. Es lo que pasó en 2024-2025.
Base	50 %	4,2 %	6,0 %	8,4 %	465,14	+9,4 %	Se cumple la guía de 2026 (BPA ajustado ≥ 27) y el +12 % de 2027; las subidas de primas y la salida de mercados con pérdidas devuelven el margen EBITDA al 6,0 % de 2023-2024 en 2030, con ingresos al 4-5 % anual, por debajo del gasto sanitario.
Alcista	25 %	5,2 %	6,4 %	8,4 %	545,48	+28,3 %	Medicaid vuelve a margen positivo con tarifas actualizadas por los estados, Carelon crece con terceros y el margen supera en 0,4 puntos al base; los ingresos crecen un punto más con el envejecimiento y nuevas licitaciones.



Valor ponderado por probabilidad: 443,24 USD (+4,2 %).

La asimetría es de 0,94 veces con nuestro coste de capital: el alcista gana un 28,3 % (545,48 USD) y el bajista pierde un 30,1 % (297,18 USD), y el valor ponderado queda cerca del precio. El bajista no es cosmético: es el margen de 2025 prolongado, lo que ya vivió la empresa y lo que hoy viven Centene y Molina [29, 30]. Con la prima implícita del mercado, la asimetría sube a 2,39 veces. A este precio el perfil no compensa con nuestro WACC.

22. Suma de partes

Confianza: Baja

No aplica: sin cifras de segmentos accesibles (la nota del 10-K no se pudo leer) y con CarelonRx y Carelon Services muy ligados a los afiliados propios; el valor depende del margen del seguro.

23. Síntesis de valoración

Confianza: Media



Método	Mínimo	Central	Máximo
Cotización 52 semanas	274,84	425,27	436,24
Precio objetivo de los analistas	360,00	451,38	498,00
Comparables: PER NTM	311,57	405,40	556,53
Transacciones precedentes (EV/EBITDA)	457,94	646,76	651,10
DCF (WACC y g ± 0,5)	414,03	465,14	536,60
Escenarios (bajista – alcista)	297,18	443,24	545,48
DCF con la prima del mercado	490,67	535,11	589,06
Precio actual	423,14	425,27	427,40

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	465,14	+9,4 %	40 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	405,40	-4,7 %	20 %
Transacciones precedentes (no se usa)	646,76	+52,1 %	0 %
Escenarios ponderados	443,24	+4,2 %	40 %

Valor intrínseco ponderado (largo plazo): 444,43 USD (+4,5 % sobre 425,27).

El puente es del 2T26 (30-jun-2026): deuda de 31.075 M (30.700 M a largo y 375 M a corto) y solo 2.100 M de caja, la de la matriz [3, 11]. Es la decisión clave, aprendida en UnitedHealth: la caja consolidada (9.491 M a cierre de 2025) y la cartera de inversiones respaldan las reservas médicas y el capital estatutario, y su rendimiento ya está en el EBITDA; contarla añadiría ≈ 33 USD por acción (estimación propia). Pesos: DCF 40 % y escenarios 40 %, porque el valor depende de la recuperación del margen; comparables (PER) un 20 %, porque reflejan un 2026 aún deprimido; transacciones 0 %, porque no hay operación posible. La dispersión es amplia (PER de comparables 405,40 USD frente al DCF de 465,14), y el valor objetivo de 444,43 USD apenas supera el precio.

Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

Escenario	BPA	PER	De dónde sale el PER	Precio	Rentabilidad
Bajista	26,44	11,2x	mínimo de 5 años	296,13	-28,8 %
Base	33,55	14,0x	PER actual	469,70	+12,1 %
Alcista	37,29	14,8x	media histórica larga	551,89	+31,4 %

Objetivo a 12 meses (ponderado): 446,86 USD · rentabilidad +6,7 % (base +12,1 %) · señal Mantener.

Frente al consenso (solo contraste).

Nuestro BPA ajustado de 2027e (30,46 USD) supera en un 4,6 % al consenso (29,12) y el de 2028e (33,55) en un 3,3 % (32,49) [46, 47]: tomamos al pie de la letra la promesa de +12 % en 2027 y no restamos recompras porque no están anunciadas; con recompras, el BPA subiría más. Nuestro precio base (469,70 USD) queda un 4,1 % por encima del objetivo medio de los analistas (451,38, 22 analistas, en subida en tres meses) [44]. La diferencia es pequeña y sale del BPA, no del múltiplo: el PER base (14,0x) es el actual, por debajo de la mediana de cinco años.

Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.

El objetivo a 12 meses (446,86 USD, ponderado) y el valor intrínseco (444,43 USD) casi coinciden, y los dos quedan un 5 % por encima del precio: no hay una distancia que cerrar, sino poca rentabilidad que capturar. La ponderada es del 6,7 % y la del base del 12,1 %, con el dividendo del 1,6 %. La asimetría es pobre porque el bajista usa el PER mínimo de

cinco años (11,2x, el de 2024) sobre un BPA de margen hundido. Lo que subiría la cifra sería un precio más bajo, no un catalizador: la compra tendría sentido por debajo de 394,53 USD.

Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

24. Catalizadores

Confianza: Media

Fecha	Evento	Qué se sabrá	Prob.	Sentido
21-oct-2026	Resultados del 3T26 y posible ajuste de la guía de 2026 [49, 50]	Ratio de prestaciones del trimestre (89,7 % en el 2T) y primeras señales de 2027; consenso de BPA ajustado de 4,70-6,43 USD según la fuente [49]	Alta	+/−
15-oct a 7-dic-2026	Inscripción abierta de Medicare y del ACA para 2027	Cuántos afiliados pierde tras salir de condados y con el fin de los subsidios reforzados del ACA	Alta	+/−
Finales de enero de 2027	Resultados de 2026 y guía de 2027	Prueba de la promesa de +12 % de BPA ajustado sobre 2026 (≈ 30,2 USD si la base es 27) [3]	Alta	+/−
Febrero y abril de 2027	Aviso y anuncio de tarifas de Medicare Advantage para 2028 (CMS)	El de 2027 fue del +2,48 % en el anuncio final [31]	Alta	+/−
2027	Salida de estados de Medicaid y renegociación de tarifas estatales	Mejora el margen de Medicaid (−1,75 % en 2026e) a costa de ingresos [17]	Media	+

25. Riesgos y pre-mortem

Confianza: Media

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Efecto en valor	Mitigante	Señal de alerta
1	**Coste médico por encima de las primas en Medicaid y Medicare Advantage**	Operativo	Media	Alto	−30,1 % en el escenario bajista	Subidas de primas y salida de mercados con pérdidas [3, 17]	Ratio de prestaciones trimestral > 90 % fuera del 4T
2	**Tarifas públicas: Medicaid estatal, ajuste de riesgo de Medicare Advantage y fin de los subsidios del ACA**	Regulatorio	Alta	Medio	−10 a −15 % (0,5-1 punto de margen; estimación propia)	CMS subió la tarifa de 2027 al +2,48 % en el anuncio final [31]	Aviso de tarifas de 2028 por debajo del +2 %
3	**Reservas: mejoras apoyadas en desarrollo favorable de años anteriores**	Contable	Media	Medio	−5 %	Días de siniestros pendientes de 45,4 [3]	Caída de los días de siniestros pendientes o desarrollo desfavorable
4	**Caja: la matriz solo tiene ≈ 2.100 M y depende de dividendos regulados**	Financiero	Media	Medio	Menos recompras; deuda sobre capital por encima del 40 %	Flujo operativo guiado ≥ 6.000 M en 2026 [3]	Recompras trimestrales < 250 M o nueva deuda para dividendos
5	**Credibilidad de la guía: incumplida en 2024 y 2025**	Gestión	Media	Medio	PER al mínimo de 11,2x: −20 % (estimación propia)	Guía de 2026 prudente y subida dos veces [3]	Guía de 2027 por debajo de +12 % de BPA ajustado
6	**Litigios y expedientes de Medicare Advantage (codificación de riesgo, denegaciones)**	Legal	Media	Bajo	−2 a −5 %	Cerró el expediente de CMS con 342 M [12]	Provisiones nuevas en el 10-Q

Pre-mortem

Octubre de 2029: la acción vale 255 USD y ha perdido un 40 %. La recuperación de 2026 fue de precio, no de coste: las subidas de primas de 2026-2027 llegaron, pero el coste médico de Medicaid y de Medicare Advantage siguió creciendo al 8-9 % (salud conductual, fármacos de especialidad y GLP-1, cirugía ambulatoria) y los estados no actualizaron las tarifas de Medicaid. El fin de los subsidios reforzados del ACA dejó una cartera individual más pequeña y más enferma. La guía de 2027 prometía +12 % y se cumplió a medias con reservas favorables; en 2028 el ratio de prestaciones volvió al 90 %, la tercera guía incumplida en cinco años. Con la matriz sin caja, Elevance cortó las recompras y el mercado volvió a pagar 11 veces un BPA de 23 USD. Lo habrían anticipado el ratio de prestaciones de Medicaid, los días de siniestros pendientes y los dividendos de las filiales a la matriz.

26. ESG y controversias

Confianza: Baja

Asuntos materiales

Lo material son el acceso y el coste de la atención (denegaciones, autorizaciones previas) y la privacidad de los datos: Elevance sufrió en 2015 el mayor robo de datos sanitarios de EE. UU. (78,8 M de personas) y en 2026 pagó 342 M a CMS para cerrar un caso de Medicare Advantage.

Controversias

Pago de 342 M a CMS en el 2T26, que evitó sanciones en Medicare Advantage. Litigios por denegaciones y por la codificación de riesgo comunes al sector (estimación propia, sin cuantificar).

27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

Confianza: Media

#	Tema	Pregunta	Por qué importa
1	**Base de 2027**	¿Sobre qué BPA de 2026 se aplica el +12 %: el de la guía (≥ 27) o uno sin las partidas no recurrentes (≈ 0,80 USD en el 2T26 y ≈ 1 USD en el 1T26)?	Una base de 25 USD rebaja el BPA de 2027 en ≈ 2 USD y el objetivo a 12 meses en ≈ 28 USD.
2	**Medicaid**	¿Qué estados abandonan, cuántos ingresos supone y qué margen esperan en 2027 tras la salida?	Margen del −1,75 % en 2026e; es la mayor palanca del margen y del crecimiento [17].
3	**Caja de la matriz**	¿Cuántos dividendos esperan de las filiales reguladas en 2026-2027 y cuál es el colchón de capital estatutario?	La matriz tiene ≈ 2.100 M; las recompras y la deuda dependen de esos dividendos [3].
4	**Reservas**	¿Cuánto desarrollo favorable de años anteriores hay en el ratio de prestaciones de 2026?	Separa la mejora real de la contable.
5	**Carelon**	¿Qué margen operativo tienen CarelonRx y Carelon Services con terceros y qué rendimiento dan CareBridge y Paragon?	El fondo de comercio subió a 28.344 M y el ROIC bajó al 10,5 % [7].
6	**ACA**	¿Cuántos afiliados del ACA esperan perder en 2027 con el fin de los subsidios reforzados y con qué ratio de prestaciones?	El ACA compensó a los negocios públicos en el 2T26 [3].

28. Sentimiento en foros y comentarios

Confianza: Baja

Tono: Dividido · **Tendencia:** Mejora

Dónde	Fecha	Comentarios	Tono	Qué se dice
Seeking Alpha	2026-07	20	Neutro	El artículo más leído tras el 2T26 recomienda «Hold»: valoración con descuento y buena caja, pero el margen sigue presionado y no hay prueba de que el coste médico ceda [78]; Sure Dividend también mantiene «Hold» por la rentabilidad esperada [82].
Reddit (vía SentiSense)	2026-08	16	Negativo	En Reddit predominan las menciones bajistas (≈ 21 % de las menciones con sesgo bajista y atención baja, ≈ 16 al día): el debate es Medicaid, el ACA y si el sector es una «trampa de valor» [79].
Simply Wall St (comunidad)	2026-07	10	Positivo	Las narrativas de la comunidad celebran la guía subida y la salida de mercados de Medicaid con pérdidas; las valoraciones de usuarios suben el valor razonable [80].
Goldesel (lectores en alemán)	2026-05	5	Positivo	Los lectores comentan la subida de Deutsche Bank a «Buy» (498 USD) y la compra de acciones de la consejera delegada como señal de suelo [81].
Benzinga (opciones y cortos)	2026-08	0	Positivo	Posición corta baja (≈ 2,9 % del capital flotante) y ratio put/call de 0,40: el mercado de opciones no apuesta contra la acción [54].

Tema	Postura	Peso	Qué dicen los datos
Coste médico en Medicaid y Medicare	Bajista	Alto	Con razón: el ratio de prestaciones del 2T26 subió 80 pb al 89,7 % por los negocios públicos y la dirección prevé un margen operativo de Medicaid del −1,75 % en 2026.
¿Ha tocado fondo el sector?	Dividida	Alto	Las cifras apoyan un suelo en 2026: guía subida dos veces y vuelta prometida a +12 % de BPA en 2027; pero 2024 y 2025 se incumplieron.
Valoración barata frente a la historia	Alcista	Medio	Exagerado tras la subida a 425 USD: 15,7 veces el BPA ajustado de 2026e, por encima de la mediana de cinco años (14,2x).
Salida de mercados de Medicaid y del ACA	Alcista	Medio	Mejora el margen pero resta ingresos en 2027: lo recogemos con un crecimiento del 3 % ese año.

El sentimiento no es extremo: los particulares siguen escépticos (Reddit bajista) mientras los analistas son mayoritariamente compradores (15 de 23) y los cortos son bajos. Desde julio el tono mejora con la guía subida y el rebote de la acción (de 373 a 425 USD), lo que reduce el margen de seguridad que veían los inversores de valor en primavera. Ningún foro aporta un riesgo que el informe no recoja; el tema que más pesa, el coste médico de Medicaid, es también nuestro principal riesgo. Antes del 3T26 (21-oct) el mercado ya descuenta un buen trimestre tras el de UnitedHealth.

Opiniones de inversores en foros, redes y comentarios de prensa: sirven para saber qué preocupa o entusiasma al mercado, no como fuente de cifras. No entran en la valoración.

Anexos

A. Controles de calidad del análisis

16 de 16 controles correctos. Fuentes: 82 (31 primarias); citas distintas en el texto: 81.

Control	Resultado	Detalle
DCF inverso calculable	OK	–
Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF	OK	–
Circulante del primer año de proyección ≈ último real	OK	Supuesto 0,0 % frente a 0,0 % real: genera una variación de circulante de 0 M en el primer año. Converge de forma gradual.
Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa	OK	71 %.
Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %	OK	3,00 %.
Probabilidades de los escenarios suman 100	OK	–
Al menos 5 comparables	OK	8 comparables.
Pesos de la síntesis suman 100	OK	–
Múltiplos del objetivo a 12 m según la regla común	OK	–
Objetivo 12 m frente al consenso	OK	El base se separa un 4,1 % del objetivo medio de los analistas: explícalo en diferencia_consenso (nunca se acerca la cifra).
Recomendación coherente con la regla de decisión	OK	–
La síntesis explica la convicción	OK	La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría.
Al menos 25 fuentes	OK	82 fuentes (31 primarias).
Al menos 10 fuentes primarias	OK	31.
Toda cita [n] existe en fuentes	OK	–
Fuentes sin citar ≤ 15 %	OK	Sin citar: 53.

Tipo de fuente	Número
Primaria	31
Datos de mercado	22
Prensa	10
Analistas	7
Sectorial	7
Foros y redes	5

B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

Sección no incluida	Tipo
16. Comportamiento en bolsa	Complemento

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
negocio	segmentos (ingresos y resultado por segmento 2021-2025)	Núcleo	1) 10-K 2025 (sec.gov) no accesible desde la nube; 2) búsqueda de la nota de segmentos en prensa y agregadores; 3) comunicados trimestrales: solo cifras del grupo	Omitido
balance	vencimientos de la deuda	Complemento	1) nota de deuda del 10-K no accesible; 2) búsqueda en prensa; 3) agregadores: sin calendario	Omitido
flujos	adquisiciones (salidas de caja anuales)	Complemento	1) estado de flujos del 10-K no accesible; 2) Stock Analysis y Finboard citados sin esa línea en la búsqueda; 3) prensa: importes sueltos, no la línea anual	Omitido
esg	calificaciones	Complemento	1) web de Sustainalytics no accesible; 2) búsqueda MSCI ESG Elevance; 3) informe de sostenibilidad no accesible	Omitido
gobierno	consejo completo, independencia y comisiones	Núcleo	1) proxy DEF 14A 2026 en sec.gov (no accesible desde la nube); 2) PDF del proxy en q4cdn (no accesible); 3) búsqueda de prensa: sin la lista	Omitido
gobierno	voto de remuneración y accionistas significativos	Complemento	1) 8-K de la junta de mayo de 2026; 2) proxy; 3) prensa: sin el resultado del voto	Omitido
bolsa	rentabilidades, beta, volatilidad y caída máxima	Complemento	1) bolsa.mjs (Yahoo) sin red en la nube; 2) búsqueda de rentabilidades anuales; 3) Macrotrends y Trade Ideas: solo cierres y rango	Omitido
consenso	ingresos y EBITDA de consenso	Complemento	1) Stock Analysis forecast (sin tabla en la búsqueda); 2) MarketScreener no accesible; 3) Barchart y Zacks: solo BPA	Omitido
sentimiento	Reddit y Stocktwits leídos directamente	Complemento	1) búsqueda de hilos en Reddit; 2) Stocktwits ELV; 3) agregador SentiSense (usado)	Calculado y marcado como estimación
gobierno	presidencia del consejo (separada o no de la consejera delegada) y consejero coordinador	Núcleo	1) proxy DEF 14A 2026 (sec.gov, no accesible); 2) PDF del proxy en q4cdn (no accesible); 3) búsqueda de prensa: sin el dato	Omitido

Fuentes

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
1	Elevance Health, informe anual 10-K 2025	Elevance Health (SEC)	Primaria	6 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000013/elv-20251231.htm
2	Elevance Health Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC)	Primaria	28 ene 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000006/a4q2025elvearningsrelease.htm
3	Elevance Health Reports Second Quarter 2026 Results, Raises Full Year Guidance (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC)	Primaria	15 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001156039/000115603926000058/a2q2026elvearningsrelease.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
4	Elevance Health Reports First Quarter 2026 Results; Raises Full-Year Guidance (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC)	Primaria	22 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001156039/000115603926000039/a1q2026elvearningsrelease.htm
5	Elevance Health (ELV): income statement	Stock Analysis	Datos de mercado	oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/financials/income-statement/
6	Elevance Health (ELV): cash flow statement	Stock Analysis	Datos de mercado	oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ELV/financials/cash-flow-statement/
7	Elevance Health (ELV): balance sheet	Stock Analysis	Datos de mercado	oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ELV/financials/balance-sheet/
8	Elevance Health: datos XBRL de las cuentas (pretax income, interest expense)	EDGAR Tools	Datos de mercado	oct 2026	https://app.edgar.tools/companies/ELV
9	Elevance Health Inc (NYSE:ELV): depreciación anual	Kalkine Media	Datos de mercado	oct 2026	https://kalkinemedia.com/ca/companies/nyse-elv
10	ELV beats Q1 earnings estimates on rising net investment income	Zacks	Prensa	22 abr 2026	https://www.zacks.com/stock/news/2905868/elv-beats-q1-earnings-estimates-on-rising-net-investment-income
11	Elevance Health (ELV) up 6.8% since last earnings report (balance del 2T26)	Zacks / Eastern Progress	Prensa	ago 2026	https://www.easternprogress.com/elevance-health-elv-up-6-8-since-last-earnings-report-can-it-continue/article_d774124b-ba20-53cc-9499-8cc3118d71c7.html
12	Elevance reports $1.5B profit in Q2, membership dip	Becker's Payer Issues	Prensa	15 jul 2026	https://www.beckerspayer.com/?p=26606
13	Elevance Health (ELV): cash flow (recompras y dividendos)	Finboard	Datos de mercado	oct 2026	https://finboard.net/companies/ELV/cash-flow
14	Elevance Health (ELV), informe de Sure Dividend de enero de 2024 (BPA ajustado de 2023)	Sure Dividend	Analistas	25 ene 2024	https://www.suredividend.com/wp-content/uploads/2024/01/ELV-2024-01-25.pdf
15	Elevance Health, resultados del 4T22 (8-K, exhibit 99.1)	Elevance Health (SEC)	Primaria	25 ene 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000119312523014676/d418386dex991.htm
16	Anthem / Elevance Health: financials 2018-2020	Stockalarm	Datos de mercado	oct 2026	https://pro.stockalarm.io/quote/ANTM/financials
17	Elevance preparing to exit several Medicaid states	Healthcare Innovation	Prensa	jul 2026	https://www.hcinnovationgroup.com/policy-value-based-care/health-insurance/news/55391795/elevance-preparing-to-exit-several-medicaid-states
18	Elevance Health (ELV) income statement TTM	OpenCapital	Datos de mercado	oct 2026	https://www.opencapital.sh/stocks/elv/metrics/income-statement?period=ttm
19	Elevance Health, informe trimestral 10-Q del 3T25	Elevance Health	Primaria	22 oct 2025	https://s202.q4cdn.com/665319960/files/doc_financials/2025/q3/3Q2025ELV10Q.pdf

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
20	UnitedHealth Group, informe anual 10-K 2025	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	2 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000062/unh-20251231.htm
21	UnitedHealth Group, informe trimestral 10-Q del 2T26	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	10 ago 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000197/unh-20260630.htm
22	NHE Fact Sheet (National Health Expenditures 2024)	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	jun 2026	https://www.cms.gov/data-research/statistics-trends-and-reports/national-health-expenditure-data/nhe-fact-sheet
23	National Health Expenditure Projections 2025-2034: Forecast Summary	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	24 jun 2026	https://www.cms.gov/files/document/nhe-projections-forecast-summary.pdf
24	NHE Projections 2025-2034, Table 1: National Health Expenditures and Selected Economic Indicators	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	24 jun 2026	https://www.cms.gov/files/zip/nhe-projections-tables.zip
25	Medicare Advantage in 2026: Enrollment Update and Key Trends	KFF	Sectorial	5 jun 2026	https://www.kff.org/medicare/medicare-advantage-in-2026-enrollment-update-and-key-trends/
26	The Cigna Group, informe anual 10-K 2025	The Cigna Group (SEC)	Primaria	26 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1739940/000173994026000006/ci-20251231.htm
27	CVS Health, informe anual 10-K 2025	CVS Health (SEC)	Primaria	10 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000006480326000010/cvs-20251231.htm
28	Humana, informe anual 10-K 2025	Humana (SEC)	Primaria	19 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49071/000049071260000009/hum-20251231.htm
29	Centene, informe anual 10-K 2025	Centene (SEC)	Primaria	17 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071739/000107173926000049/cnc-20251231.htm
30	Molina Healthcare, informe anual 10-K 2025	Molina Healthcare (SEC)	Primaria	10 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1179929/000117992926000005/moh-20251231.htm
31	2027 Medicare Advantage and Part D Rate Announcement (fact sheet)	CMS	Primaria	6 abr 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2027-medicare-advantage-part-d-rate-announcement
32	2027 Medicare Advantage and Part D Advance Notice (fact sheet)	CMS	Primaria	26 ene 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2027-medicare-advantage-part-d-advance-notice

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
33	2026 Medicare Advantage and Part D Rate Announcement (fact sheet)	CMS	Primaria	7 abr 2025	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2026-medicare-advantage-part-d-rate-announcement
34	The Top Pharmacy Benefit Managers of 2025	Drug Channels Institute	Sectorial	30 mar 2026	https://www.drugchannels.net/2026/03/the-top-pharmacy-benefit-managers-of.html
35	Competition in Health Insurance: A Comprehensive Study of U.S. Markets (actualización 2025, datos 2024)	American Medical Association	Sectorial	dic 2025	https://www.ama-assn.org/system/files/competition-health-insurance-us-markets.pdf
36	Chairman Guthrie Celebrates Long-Awaited PBM Reform Being Signed into Law	Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU.	Primaria	5 feb 2026	https://republicans-energycommerce.house.gov/posts/chairman-guthrie-celebrates-long-awaited-pbm-reform-being-signed-into-law
37	UnitedHealth Group, nota de prensa de resultados del 2T26	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	16 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000191/earningsrelease2q26_7152.htm
38	Elevance Health, proxy statement (DEF 14A) 2026	Elevance Health (SEC)	Primaria	26 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000031/elv-20260326.htm
39	Elevance Health's 5 highest-paid executives in 2025	Becker's Payer Issues	Prensa	abr 2026	https://www.beckerspayer.com/workforce/elevance-healths-5-highest-paid-executives-in-2025
40	Elevance Health: CEO kauft Aktien für rund 1 Mio. Dollar	Goldesel	Prensa	2026	https://goldesel.de/aktien/news/elevance-health-ceo-kauft-aktien-fur-rund-1-mio-dollar-kurs-bleibt-nach-guidance-delle-unter-druck
41	Elevance Health stock tumbles 12% on Q3 earnings miss (2024)	Investing.com	Prensa	17 oct 2024	https://investing.com/news/stock-market-news/elevance-health-stock-tumbles-12-on-q3-earnings-miss-93CH-3667964
42	Health insurance stocks slide after Elevance highlights margin pressures	Finviz / Reuters	Prensa	jul 2025	https://finviz.com/news/368594/health-insurance-stocks-slide-after-elevance-highlights-margin-pressures-elv
43	Elevance Health (ELV) stock price & overview (cierre del 13-oct-2026)	Stock Analysis	Datos de mercado	13 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/
44	Elevance Health (ELV) stock forecast & analyst price targets	Stock Analysis (S&P Global)	Analistas	13 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/forecast/
45	Elevance Health (ELV) price target and analyst ratings	MarketBeat	Analistas	oct 2026	https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/ELV/forecast/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
46	FY2026 EPS estimates for Elevance Health boosted by analyst (Zacks 2027-2028)	MarketBeat	Analistas	29 jul 2026	https://www.marketbeat.com/instant-alerts/fy2026-eps-estimates-for-elevance-health-boosted-by-analyst-2026-07-29/
47	Elevance Health's Q2 2026 earnings: what to expect	Barchart	Analistas	jul 2026	https://www.barchart.com/story/news/12224/elevance-health-s-q2-2026-earnings-what-to-expect
48	ELV stock info (2-oct-2026, rango de 52 semanas)	Trade Ideas	Datos de mercado	2 oct 2026	https://www.trade-ideas.com/stock-info/ELV/
49	Elevance Health (ELV) set to announce quarterly earnings on Wednesday	Defense World	Prensa	14 oct 2026	https://www.defenseworld.net/2026/10/14/elevance-health-elv-set-to-announce-quarterly-earnings-on-wednesday.html
50	Elevance Health conference call Q3 2026 results	BioPharmaWatch	Prensa	5 oct 2026	https://www.biopharmawatch.com/news/ELV/elevance-health-conference-call-q3-2026-results
51	Elevance Health: 24 year stock price history	Macrotrends	Datos de mercado	oct 2026	https://macrotrends.net/stocks/charts/ELV/elevance-health/stock-price-history
52	Elevance Health stock analysis: guidance raised to $27, street high at $498	TIKR	Analistas	jul 2026	https://www.tikr.com/blog/elevance-health-stock-analysis-guidance-raised-to-27-street-high-at-498-tikr-target-at-534
53	Elevance Health Inc. (ELV) stock forecast	Tickflow	Analistas	31 jul 2026	https://tickflow.io/stock/ELV/forecast
54	Elevance Health Inc: sentiment (posición corta)	Benzinga	Datos de mercado	ago 2026	https://www.benzinga.com/quote/ELV/sentiment
55	UnitedHealth Group (UNH) statistics	Stock Analysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/unh/statistics/
56	The Cigna Group (CI) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ci/statistics/
57	CVS Health (CVS) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cvs/statistics/
58	Humana (HUM) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/hum/statistics/
59	Centene (CNC) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cnc/statistics/
60	Molina Healthcare (MOH) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/moh/statistics/
61	Oscar Health (OSCR) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/oscr/statistics/
62	Alignment Healthcare (ALHC) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/alhc/statistics/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
63	10-Year Treasury Constant Maturity Rate (DGS10)	Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)	Datos de mercado	8 oct 2026	https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
64	Implied ERP by month (ERPbymonth.xlsx)	Aswath Damodaran, NYU Stern	Datos de mercado	oct 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx
65	Betas by Sector (US), enero de 2026	Aswath Damodaran, NYU Stern	Sectorial	ene 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
66	Cigna to Acquire Express Scripts (exhibit 99.1 del 8-K)	Cigna / SEC	Primaria	8 mar 2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/701221/000095015918000059/ex99-1.htm
67	CVS Health to Acquire Aetna (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	4 dic 2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000119312517359526/d482402dex991.htm
68	OptumInsight and Change Healthcare Combine (exhibit 99.1 del 8-K)	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	6 ene 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000119312521002419/d60247dex991.htm
69	Amedisys and Optum to Combine (exhibit 99.1 del 8-K)	Amedisys / SEC	Primaria	26 jun 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/896262/000110465923074547/tm2319648d1_ex99-1.htm
70	CVS Health to Acquire Signify Health (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	6 sep 2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000119312522238311/d344935dex991.htm
71	Express Scripts Holding, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	feb 2018	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001532063.json
72	Aetna, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	feb 2018	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001122304.json
73	Change Healthcare, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	may 2021	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001756497.json
74	Amedisys, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	may 2023	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000896262.json
75	Signify Health, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	mar 2022	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001828182.json
76	CVS Health to Acquire Oak Street Health (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	8 feb 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000094787123000133/ss1747225_ex9901.htm
77	Humana to acquire remaining interest in Kindred at Home (exhibit 99.3 del 8-K)	Humana / SEC	Primaria	28 abr 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49071/000004907121000079/exhibit993kindredathome-.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
78	Elevance Health Has Upside, But Not Yet A Buy (artículo y comentarios)	Seeking Alpha	Foros y redes	28 jul 2026	https://seekingalpha.com/symbol/ELV/analysis
79	Elevance Health (ELV) sentiment: Reddit, noticias y redes	SentiSense	Foros y redes	10 ago 2026	https://app.sentisense.ai/stocks/ELV/sentiment
80	Elevance Health (ELV) raises 2026 targets and exits weak Medicaid markets (comentarios y valoraciones de la comunidad)	Simply Wall St	Foros y redes	jul 2026	https://simplywall.st/stocks/us/healthcare/nyse-elv/elevance-health/news/elevance-health-elv-raises-2026-targets-and-exits-weak-medic/amp
81	Elevance Health: Analystenupgrade auf Buy – Kursziel auf 498 USD erhöht (comentarios de lectores)	Goldesel	Foros y redes	may 2026	https://goldesel.de/aktien/news/elevance-health-analystenupgrade-auf-buy-kursziel-auf-498-usd-erhoht
82	ELV: informe de Sure Dividend (julio de 2026)	Sure Dividend	Foros y redes	16 jul 2026	https://www.suredividend.com/wp-content/uploads/2026/07/ELV-2026-07-16.pdf

Control de calidad del informe

Campos con dato: **78,8 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **gobierno, bolsa** · Generado el 14 oct 2026.

Entorno en la nube con solo búsqueda web: sec.gov, la web de la empresa, Yahoo y MarketScreener no se abren, así que las cifras salen de los comunicados de resultados (8-K) y del 10-K tal como los citan los resultados de búsqueda, y de agregadores (Stock Analysis, EDGAR Tools, Finboard, Kalkine, OpenCapital) con su URL [5, 8, 9, 13, 18]; el balance de 2024 se contrasta con el 10-Q del 3T25 [19]; confianza media en cuentas y baja en gobierno. Precio de cierre del 13-oct-2026 (425,27 USD): la sesión del 14-oct no había cerrado. Ingresos = ingresos operativos (sin la renta de inversiones); EBIT = beneficio antes de impuestos + gastos por intereses, que sí incluye el rendimiento de la cartera de las filiales reguladas; por eso el puente solo cuenta la caja de la matriz (≈ 2.100 M a 30-jun-2026) y no los 9.491 M de caja consolidada (lección de UnitedHealth). Amortizaciones de 2022-2024 interpoladas entre las de 2021 y 2025 (estimación propia); deuda financiera de 2021-2024 = deuda total del agregador menos ≈ 700 M de arrendamientos (estimación propia; 2025 de la nota de deuda). Sin segmentos ni circulante comercial (clientes, proveedores, reservas médicas): no se pudieron leer las notas del 10-K. Comparables y transacciones del informe de UnitedHealth (cifras del 9-12 oct-2026); UnitedHealth entra con las de su informe, antes de sus resultados del 3T26. Elevance publica el 3T26 el 21-oct-2026, una semana después del corte.

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.